

分类号：

单位代码：10441

密 级：

学 号：201502159



山东中医药大学

硕士学位论文

中文题目：月经病从脾胃论治的理论及应用研究

英文题目：Study on Theory and Application of
Treating Menstrual Disease from
Spleen and Stomach

申请人姓名	王 娇
入 学 年 月	2015 年 9 月
学 科 专 业	中医妇科学
指 导 教 师	刘 卉
学 位 类 型	中医专业学位

2018 年 6 月 15 日

提 要

目的：分别从月经病脾胃论治的理论研究、知网的现代文献研究及临床中的典型病例分析三个方面，探讨月经病从脾胃论治的历史发展轨迹、治法及用药规律。

方法：第一部分检索《中华医典》中收录的 1840 年以前的有代表性的中医古籍，按时间顺序梳理分析该治法在妇科月经病治疗中的应用；第二部分以中国知网途径检索 1987 年至 2017 年的现代文献，运用统计学软件对常用治法及用药规律进行分析；第三部分挑选临床中最能体现常用治法的典型病例进行分析。

结果：第一部分可知月经病从脾胃论治的理论来源于《黄帝内经》，秦汉时期的张仲景已具体应用于临床，隋唐时期的巢元方、孙思邈，两宋时期的陈自明等均在其治疗妇科病中有所体现，辽夏金元时期的金元四大家在前人基础上完善了该治法，明清时期的医家丰富了该理论，并进行了发挥。第二部分分析现代文献得出，从脾胃论治的方法几乎涵盖全部月经病种类，其中最多应用于闭经、崩漏和月经后期。临床中常用的治法有八种，出现频次前三位的治法为：健脾补肾、健脾疏肝和补益气血（以下简称“调脾胃三法”），分别对调脾胃三法常用药物研究发现，应用最多的药类为补虚药，每种治法中药物的药性、药味、归经各有侧重，常用药物大体以温性为主，味多甘、苦、辛，归肝、脾、心、肾经，常用的配伍方剂包括逍遥散、四物汤、举元煎等基本方。第三部分通过病案举例分析从脾胃论治月经病的临床应用。

结论：调脾胃三法临床应用颇多，结合历代研究及现代文献研究发现，月经病以气血虚证为主，补虚的同时需要兼顾脾和其他脏腑的关系，“久病及肾”应脾肾双补，“女子以肝为先天”，健脾不忘疏肝。临床中不同的月经病，虽然表现的临床症状不同，但因病机相同，辨病识证，谨守病机，均可从脾胃论治。

关键词 月经病；脾胃；理论研究；用药规律；病例分析

Study on Theory and Application of Treating Menstrual Disease from Spleen and Stomach

Speciality:Gynecology of TCM

Author:Wang Jiao

Tutor:Liu Hui

Abstract

Objective:From the theoretical study of menstrual spleen-stomach treatment, modern literature research of CNKI.com and clinical typical case analysis, the historical development of menstrual pathology and the modern medication laws were discussed.

Methods:The first part of the "Chinese Medical Dictionary" in the collection of the 1840 before the representative of the ancient Chinese medicine books, according to the time sequence analysis of the treatment of gynecological menstrual diseases in the application; the second part of the China Knowledge Network and other ways to retrieve 1987 In the modern literature from year to 2017, statistical software was used to analyze the common treatments and medication laws. In the third part, the typical cases that most commonly reflect the common treatments were selected for analysis and reporting.

Result:The first part shows that the theory of treating menstrual diseases from the spleen and stomach is based on the Yellow Emperor's Internal Classics. Zhang Zhongjing in the Qin and Han Dynasties has been used in clinical practice. During the Sui and Tang Dynasties, Chao Yuanfang and Sun Siyun, and during the Song Dynasty, Chen Ziming were all involved in the treatment of gynecological diseases. This was reflected in the fact that the four people of Jin and Yuan in the Liao and Jin-Yuan periods perfected the Governing Law on the basis of their predecessors. The doctors in the Ming and Qing Dynasties

enriched the theory and played it. The second part analyzes the modern literature and concludes that the method of treatment from spleen and stomach covers almost all types of menstrual disorders, and most of them apply to amenorrhea, uterine bleeding, and late menstruation. There are eight kinds of governing methods that are commonly used in clinical practice. The top three frequency treatments are: spleen and kidney, spleen and liver rejuvenation, replenishing qi and blood, which are hereinafter referred to as “three methods for regulating spleen and stomach”. Each type of menstrual disorder has its own corresponding The preferred method. In addition, the three commonly used drugs for the spleen and stomach were studied and found that the most widely used drugs were tonics. Each of the drugs in the treatment had medicinal properties, medicinal tastes, and palliative qualities. The commonly used drugs were mainly warm and tasteful. , bitter, symplectic, liver, spleen, heart, kidney Jing, commonly used drug combinations include Xiaoyaosan, Siwu Tang, Juyuan fried and other basic parties. The third part of the treatment of menstrual disorders should pay attention to the usual conditioning, menstrual disease should be treated during the period of its standard, after the culture of this book.

Conclusion:Spleen and stomach three clinical application of many, combined with the study of ancient literature and modern literature found that menstrual Qi and blood deficiency-based, tonic at the same time need to take into account the relationship between the spleen and other organs, “chronic illness and kidney” should be spleen and kidney Double make up, “the woman takes liver as innate”, spleen does not forget Shugan. Different clinical menstrual disease, although the performance of different clinical symptoms, but the same pathogenesis, disease identification card, keep the pathogenesis, can be treated from the spleen and stomach.

Keywords menstrual disease;spleen and stomach;theoretical research;medication law;case analysis.

目 录

引 言	1
第一部分 月经病从脾胃论治的理论研究	2
1. 春秋战国时期（公元前 770～公元前 221 年）	2
2. 秦汉时期（公元前 221 年～220 年）	2
3. 三国两晋南北朝（220 年～581 年）	3
4. 隋唐五代（581 年～960 年）	3
5. 两宋时期（960 年～1279 年）	4
6. 辽夏金元时期（916 年～1368 年）	4
6.1 河间学派	4
6.2 易水学派	5
6.3 丹溪学派	6
7. 明代（1368 年～1644 年）	7
8. 清代（1644 年～1911 年）	8
9. 小结	9
第二部分 现代文献研究	10
1. 文献资料与研究方法	10
1.1 文献资料	10
1.2 研究方法	10
2. 研究结果	11
2.1 月经病从脾胃论治病种统计结果	11
2.2 常用调脾胃法频数统计结果	12
2.3 八种调理脾胃的方法治疗月经病统计结果	13
2.4 调脾胃三法药物频数统计结果	15
2.5 调脾胃三法使用药类频数统计结果	17
2.6 调脾胃三法药性频数统计结果	19
2.7 调脾胃三法药味频数统计结果	20

2.8 调脾胃三法药物归经频数统计结果.....	21
2.9 调脾胃三法聚类分析结果.....	21
3. 讨论部分	22
3.1 月经病从脾胃论治的病种讨论.....	22
3.2 常用的调理脾胃方法的讨论.....	22
3.3 调理脾胃的方法治疗月经病的讨论.....	25
3.4 调脾胃三法高频药物讨论.....	26
3.5 调脾胃三法的药类性味归经讨论.....	30
3.6 调脾胃三法的聚类药物组合讨论.....	30
3.7 月经病异病同治的讨论.....	32
第三部分 典型病案分析	33
结 语	37
参考文献	38
综 述	41
致 谢	47
发表论文	48

引 言

《医宗金鉴·妇科心法要诀》概括：“男妇两科同一治，所异调经崩带癥，嗣育胎前与产后，前阴乳疾不相同。”由于妇人具有独特的生理特点，因而中医妇科学研究内容包括了病理因素所致的经、带、胎、产、杂多种疾病，其中月经病是其中的一大类，被称为妇科病之首，调经是中医妇科临床的特色和优势。

传统的中医妇科学认为正常的经血产生与脏腑、天癸、经络、气血等方面的共同作用相关。不同的辨证体系只是不同的工具，其中脏腑辨证是中医学辨证的根本，五脏在经血的产生中各司其职。脏腑之中，脾胃居人体的中焦，是气机升降出入、气血津液运行上下之枢纽，因而心血灌注、肺气充畅、肝血归藏、肾精滋养，及元气输布，均依赖脾胃的升降纳运。可见脾胃在其中发挥着不可或缺的作用，脾胃健运，则生化有源，血有常道可循，血海得以充盈，月事正常。

另有《女科要旨》认为，古代把月经叫做月信，命名相当确切，月经的周期、经期、经量均包含于“信”字之中。可理解成，五行之土，犹如五常之信，犹如五脏之脾。脾为阴土，胃为阳土，都属于信，脾胃和则月事以时下，脾胃不和则失“信”，则月经不调。因此本论文研究月经病从脾胃论治的理论和应用，具有一定的意义。

本论文第一部分探索月经病从脾胃论治的历史发展沿革，总结各个历史时期代表医家的学术思想及理论经验；第二部分通过搜集整理近 30 年月经病从脾胃论治的临床文献，对该治法在中医妇科治疗月经病的应用进行全面的总结，探索其中的常用方法及用药规律等；第三部分挑选临床中最能体现常用治法的典型病例进行分析，从而证实月经病从脾胃论治疗效确切，证实该法在妇科临床应用的意义。

第一部分 月经病从脾胃论治的理论研究

月经病的发生与脏腑、天癸、气血、经络的失调有关，而脏腑辨证为诸多辨证的根本，五脏在经血的产生中各自发挥着重要的作用。其实，脏腑、天癸、气血、经络均能通过脾的功能联系起来。历代医家著作中均有论及：

1. 春秋战国时期（公元前 770～公元前 221 年）

这一时期是中医理论的奠基时期，出现了妇科医生和医学专著，也是月经病从脾胃论治的理论奠基阶段，首次提出了心脾相关的理论依据。

这一时期出现的《黄帝内经》^[1]，在解剖、生理、病因病机、诊断、治疗等方面对妇科的临床提供了重要的指导意义。其中《素问·阴阳别论篇第七》提出“二阳之病发心脾……女子不月”。张景岳《类经·阴阳发病》^[2]认为，二阳在这里指的是阳明，即胃和大肠两条经脉。由于大肠小肠皆属于胃，因而这句话主要是在论述“女子不月”和胃的关系，心与胃为母子关系，脾和胃为表里关系，若情伤心，则母病及子，若劳伤脾，则脏病及腑。隐曲在古籍当中尚存在争议，然二阳历代医家大多认为属阳明。这段话最早论及了脾胃和脏腑、经络及月经的关系，论及了闭经的病机。另外，《素问·至真要大论篇第七十四》提出“诸湿肿满，皆属于脾”，说明痰湿和脾胃的关系，痰湿可引起月经后期、闭经、多囊卵巢综合征等多种月经病，这就为后世从脾胃论治月经病提供了理论依据。女子以冲任为本，“冲为血海”，《黄帝内经》最早提出冲脉与阳明有多处交会，任脉主胞胎联系太阴经，可见脾胃和经脉，脾胃和月经之间密不可分的关系。

综上，《黄帝内经》将月经不调的病因归于脾胃不和、心脾两虚、痰湿阻滞、冲任不调等。

2. 秦汉时期（公元前 221 年～220 年）

这一时期，出现了被誉为“方书之祖”的《伤寒杂病论》，仲景已经开始重视从中焦脾胃调理内科病、妇科病。

张仲景在《伤寒论》^[3]提出“四时皆以胃气为本”，“四季脾旺不受邪”，将重

视脾胃的学说贯穿到底，在《黄帝内经》的基础上进行了发挥，具体体现在病因病机、治疗、治疗后的护理方方面面。书中载方 113 首，顾护脾胃的有 61 首之多，比如耳熟能详的桂枝汤、十枣汤、白虎加人参汤、小建中汤、四逆汤、四逆散、五苓散等等。《金匮要略》^[4]亦时时重视脾胃，《妇人杂病篇》中有因血而致病者，有因气而致病者，或气血同时致病，因而重视调理脾胃气血。其篇中有“妇人腹中诸疾病，当归芍药散主之”，当归芍药散即体现了从肝、脾调理妇科疾病的思想，此外还有广泛应用于临床的温经汤、胶艾汤、当归生姜羊肉汤等均体现了妇科病重视调理脾胃的思想，对后世处方用药具有指导意义，开创了从脾胃调理月经病的先河。

张仲景临床治内伤杂病除了重视脾胃，在其《金匮要略》中还将月经不调的原因归因于肝脾不调，首次体现了调理月经病重视脾胃和其他脏腑关系的观点。

3. 三国两晋南北朝（220 年～581 年）

这一时期出现了综合的著作和产科专著，如王叔和的《脉经》^[5]，首次提出了“月经”的病名，沿用至今。但因当时社会的动荡不安，这一时期的医学著作至今流传下来的不多。

4. 隋唐五代（581 年～960 年）

这一时期，妇科发展开始趋向专科化。这一时期的医家，巢元方明确提出了月经病重视调脾胃的观点，孙思邈尤其注意顾护“脾胃阳气”。

巢元方在《诸病源候论·妇人杂病诸候一》^[6]首次提出：“肠中鸣，则月事不来，病本于胃”，可见脾胃虚弱，无力运化，气血乏源，是造成月经不至的重要原因。

同一时代著名的医药学家孙思邈，他的著作《千金方》^[7]集唐以前医学之大成，其中专门设了“妇人方”3 卷，对妇科病有着独到的见解，并且十分注重养生，提出“春夏取冷太过”的观点，认为很多病的发生是与春夏贪凉、饮食不洁导致的。因而在《千金翼方·养性》有“鱼脍、生菜、生肉、腥冷之物多损于人，宜常断之”的说法。春夏时节天气温暖，人们往往疏于保暖，或贪凉，常常损伤脾胃阳气。《千金翼方·养性》亦有“常宜温食”“热食伤骨，冷食伤肺”的说法，一方面指出饮食的温度对养生的意义，另一方面也指出顾护脾胃阳气对脾胃的意义。

孙氏重视脾胃的思想亦体现在妇科临床治疗当中，他认为“妇人经病，有虚有实”，

其中补虚的方子阳起石汤（阳起石、人参、甘草、干姜、桂心、附子、续断、赤石脂、伏龙肝、熟干地黄）体现了对脾阳的顾护。另外其对产前病的治疗尤其重视脾胃的调理，青竹茹汤（二陈汤去甘草，加生姜、竹茹）、黄连汤（黄连、吴茱萸、生地黄、人参、生姜、乌梅）即体现了健脾和胃，化痰降逆的思想。

巢氏将月经迟闭的病因归纳为脾胃气血虚弱，孙氏则认为妇人疾病应重视平时的饮食调养，将月经病的原因归于平时过食寒凉所致脾胃阳气不足，痰湿内生。孙思邈养生思想及治病对脾胃的重视，宗于内经、伤寒，且在前人的基础上进行了自己的发挥，在《脾胃论》成书之前起到了承上启下的作用。

5. 两宋时期（960 年～1279 年）

宋代对妇产科贡献最大，这一时期，妇产科开始独立分科，是妇科发展史上的里程碑时期。

最为著名的当数陈自明，陈自明提出了调理气血、调理肝脾的治疗纲领，现已广泛应用于临床，后来医家在此基础上多有发挥。陈氏著有《妇人大全良方》^[8]，是首部非常完善的妇产科专著。开篇《妇人大全良方·调经门》即强调“妇人以血为基本”，提出了妇科疾病的诊治纲领，即调理气血。脾的功能正常，则气血有所化生，有所藏摄，血液在脉中正常运行而不溢出脉外，能够维持经血的正常来潮。体现其调理脾胃气血的思想。《妇人大全良方·月水不通方论》提出“妇人月水不通……损伤肝脾，但滋其化源，其经自通”，说明醉饱入房、劳累过度、吐血失血等都能伤及肝脾导致化源不足，月经不调。《妇人大全良方·暴崩下血不止方论》提出，“大法当调补脾胃为主”。陈氏在脏腑方面抓住女子先后天，以肝脾为纲，临床常见的月经过少、月经后期、闭经、不孕症等患者，有因为脾气虚不能生血的，有因为脾虚肝郁血闭的，因而在治疗上陈氏抓住了疾病的关键所在，虚者以补，郁者以通，治疗效果明确。

陈自明认为月经失调的病因应分虚实，主要由于气血不和，另外还有肝脾不调。

6. 辽夏金元时期（916 年～1368 年）

以金元四大家为代表的三大学派有着独特的见解和临床体验，他们分别从不同角度丰富了中医妇科学。主要体现在他们重视脾胃在人体的地位，重视脏腑之间的联系。河间学派重视保护胃阴，易水学派重视顾护脾阳，丹溪学派重视脾阳胃阴。

6.1 河间学派

河间学派重视脾胃的思想与仲景一脉相承，学派代表医家为刘完素和张从正。

刘完素在他的著作《素问玄机原病式·六气为病》^[9]中提出“胃属土，土为万物之母，故胃为一身之本”，也有“食入于胃，而脾为运磨，布化五味，以养五脏之气而荣养百骸”的论述，指出了脾胃的运化作用，为一身之根本。刘河间在仲景大承气汤基础上加一味甘草创制了三承气汤，以甘草护胃，是对仲景脾胃学说的继承发展。此外，刘氏提出“土为万物之母，水为万物之元，故水土同在于下，而为万物之根本也，地干而无水湿之性，则万物根本不润，而枝叶衰矣”，提出了脾肾之间的关系，在月经病来讲，肾主生殖为先天之本，脾主运化为后天之本，先天不足可以后天来补，同时要兼顾先天。刘氏在肝脾关系上亦有相关论述，“若脾胃土气虚损，则土受肝木鬼贼之邪”，从五行角度论述了肝木与脾土的关系，肝木过旺则克制脾土，反之若能温补脾胃，使脾土坚实，则不受肝邪所克。是对仲景“知肝之病，当先实脾”的发挥。肝脾不和在妇科月经病中体现的淋漓尽致，治脾不忘疏肝则疗效倍增。

张从正在《儒门事亲·指风痹痿厥近世差玄》^[10]论述说“人之四季，以胃气为本”，而“五脏六腑，四肢百骸，皆禀受于脾胃”，强调了脾胃在人身的根本地位，张氏重脾胃的思想可以体现在内科病及妇科病的治疗中。张从正是攻邪派的代表医家，攻邪之后注意保护胃气，汗、吐、下后，脏腑空虚，倡导以稀粥养胃。这提示我们，临床在治疗月经后期、闭经、多囊卵巢综合征等“痰”“湿”所引起的疾病时，不要只是一味的祛痰、化湿，同时应该注意健脾和胃。张氏在其医著《儒门事亲》中也有关于肝脾关系的论述。另外脾胃气机升降失常可导致各种疾病，月经过多、月经先期、崩漏、经期延长等等。

河间学派重视滋养胃阴，调理脾胃的方法多体现在用“汗、吐、下”法泻脾阳，以及用养阴法滋胃阴，如此阴阳气血调和，则不病，对后世月经病从脾胃调理提供了新的思路。

6.2 易水学派

这一时期的代表医家为张元素、李杲。

张元素为易水学派的鼻祖，对脾胃学说的发展有推动作用，体现在他的著作《医学启源》^[11]之中。该书中提出“脾者……消磨五谷，寄在胸中，养于四旁”、“胃气壮，则五脏六腑皆壮也”等观点，说明了脾能运化水谷，濡养四肢，脾胃壮是五脏六腑、四肢肌肉强壮的根本。张氏在用药方面将重视脾胃治疗疾病体现的淋漓尽致。比如在《医学启源·用药备旨》篇提出了许多药物的归经，升麻、白芷、石膏归阳明经；

白芍归太阴经，明确提出升麻为脾胃经的用药，对现在临床治疗崩漏、月经过多、月经先期等脾气虚不能统摄血液等疾病具有很好的指导意义。张元素对其学生李杲日后创制“脾胃学说”产生了深远的影响。

李杲对妇人病的独特见解和丰富经验，载于《兰氏秘藏》一书，然而其对妇科影响更大的为另外的《脾胃论》^[12]一书。东垣提出了“内伤脾胃，百病由生”的著名观点，影响了内外妇儿科的疾病治疗。其指出“真气又名元气”，脾胃为元气的根本，同时还注意脾胃阳气的升发。临床创制了甘温除热、升阳举陷的补中益气汤，广泛应用于治疗崩漏等月经病，因为李氏认为崩漏是由于气虚有火，不能固摄，治以升阳泻火即可痊愈。总而言之，李氏治疗月经病的思想与他的元气阴火思想有关，认为月经病多由脾胃虚弱、中气下陷、阴火亢盛有关，治疗上注意补益脾胃气血，温补脾阳同时泻火。

6.3 丹溪学派

代表医家朱丹溪为河间学派的继承者，在前人的基础上，扩大了脾胃学说在临床中的应用范围，重视补脾阳滋胃阴。

朱丹溪认为脾胃是维系人体健康的根本，如在《丹溪心法》^[13]有言“脾具坤静之德，而有乾健之运。故能使心肺之阳降，肾肝之阴升，而成天地之交泰，是为无病之人”。这在朱氏临床中体现的淋漓尽致，对内科等疾病的诊疗常常使用补中益气汤加发散药或理中汤加附子来温养脾胃。《丹溪手镜》^[14]亦有“血者，饮食所化”的说法，认为脾胃不和导致饮食少则血不生。此外，丹溪谓“痰之为物，随气升降，无处不到”，认为痰饮生于脾胃，主要是由于太阴湿土所化。百病皆可由痰所致，在妇科而言，常见的如闭经（西医谓多囊卵巢综合征）等，治疗上可以从脾胃入手，痰为标，实脾土，燥脾湿，治其本，借鉴朱氏经验以二陈汤治疗。

金元四大家从不同角度补充了脾胃学说，既有生理上关于脾胃重要性的论述，又有从疾病角度来论述脾胃的病机，另外从治疗治法上完善了脾胃学说在内外妇儿临床中的应用。

综上，河间学派的刘完素认为，脾肾两虚、肝脾不调均可导致月经失调；张从正则认为调月经贵在调畅脾胃的气机，攻邪的同时不能忘记扶助脾胃正气；易水学派的张元素认为月经病出血证常由于脾气虚导致，李东垣则认为脾胃虚弱、中气下陷、阴火亢盛等均可导致月经不调；丹溪学派朱丹溪考虑月经不调多由于脾气虚、脾阳虚、

脾胃不和、痰湿阻滞导致，临床应注意辨证治疗。

7. 明代（1368 年～1644 年）

这一时期设立了妇人科，出现了许多妇科专著，极大的丰富了月经病的治疗，开始系统的论述脾胃和月经病的关系，分析病因与治法。

江瓘《名医类案》^[15]记载了明代以前历代名医医案 2400 余例，全书共十二卷，其中妇科医案在第十一卷共有二十门，所载医案大多从脾论治，体现了妇科病从脾入手的观点。

薛己在他的代表著作《女科撮要·经闭不行》^[16]论月经，上为乳汁，下为月水，有“因脾虚不能生血者，有因脾郁伤而血耗损者，有因胃火而消烁者，有因脾胃损而血少者”，可见，月经不能正常来潮和“脾虚”“脾郁”“胃火”等均有关系。《女科撮要·经候不调》认为心脾平和，则月经正常。并认为导致月经先期的脾的病机为“脾经血燥”或“脾经郁滞”，月经后期脾的病机多为“脾经血虚”，分别可用加味逍遥散、归脾汤和人参养荣汤治疗。《女科撮要·经漏不止》认为，因脾胃虚损引起崩漏者可予六君子汤加当归、川芎、柴胡，因脾经郁火引起的的常常用归脾汤加山栀、柴胡、丹皮。

万全在其《万氏女科》^[17]提出，妇人经候不调有三方面的原因，其一为脾虚，其二为肝郁气滞，其三为痰涎壅滞。临床重视补益心脾，他认为“二阳之病发心脾”是由于妇人思虑过度，使心脾受病，继而阳明不用，女子月事不来。治疗上重在补益心脾为其调经大法。另有脾虚月经不调者常以参术大补丸、乌鸡丸、加减补中益气汤主之。

龚廷贤《寿世保元》^[18]开篇第一章即言推崇东垣老人的《脾胃论》思想，在此基础上将内伤脾胃的病因概括为：饮食劳倦伤脾，嗜欲而伤脾，饮食自倍乃伤脾胃。治疗上提出，胃气虚可导致五脏六腑之气俱损，善于用药者，必先用胃药以培其本。该书常以千古名方补中益气汤广泛用于治疗妇科疾病。

张介宾临床注重气血辨证，在其著作《景岳全书·妇人规》^[19]提出，女子以血为本，治疗妇人的疾病，应当以调经血为先。景岳认为，天癸是女子月经的主宰，它的生成一方面依赖肾气的滋养生发，另一方面依赖后天脾胃所化精微的充养，因此注重脏腑辨证，而更侧重于脾胃肾，提出了著名的“调经之要，贵在补脾胃以资血之源，养肾气以安血之室”，现作为妇科治疗疾病的总纲。景岳临床应用当中尤重温补脾肾，

顾护阳气，调经常用五福饮、四物汤、四君子汤、八珍汤、寿脾煎、举元煎等类。

武之望《济阴纲目》^[20]对脾胃亦十分重视，体现在对闭经的治疗上，通常采用四种方法：泻火养血，大补脾胃，益阴通经和导痰降火。养血常以四物汤，泻火又分为上中下三焦，上焦火以芩连四物汤、三和散；中焦以调胃承气汤；下焦火以玉烛散泻之。历代医家关于闭经的论述颇多，武氏对该病病因病机、治疗原则进行了较完备的总结。

明代医家对月经病的病因的认识较前更明确和全面，认为导致月经不调可能的原因包括：心脾两虚、脾经血燥、脾经血虚、脾胃虚损、肝郁脾虚、痰饮阻滞、脾气虚、胃阴虚、气血两虚等。

8. 清代（1644 年～1911 年）

这一时期出现了几十种妇科专著，大多在借鉴前人基础上作出发挥，丰富了月经病从脾胃治疗的理论。

傅山所著《傅青主女科》^[21]是一部影响力巨大的中医妇科专著，书中有许多独到的见解和经验，至今妇科临床中仍在传承应用。傅氏言“凡病起于气血之衰，脾胃之虚”，重视脾胃的思想贯穿于《女科》全篇，如《傅青主女科·调经篇》认为调经不在于先治其水，而在于治血，但又不在于治血，应先治气，因为“气旺而血自生，气旺而湿自除，气旺而经自调”，由此创制的健固汤健固脾气，实为四君子汤加味。同时重视肝脾的关系，认为“年老经水复行”主要是由于肝脾不调，创制安老汤方，包含人参、黄芪、白术、甘草、香附，从五行角度讲，此方有肝气舒则脾自得养，肝的疏泄功能正常则肝能藏血而脾能统血之意。

冯兆张《女科精要》^[22]认为妇人经后发热多为“脾阴亏损”，经行泄泻多为“脾肾两虚”，治当温补脾肾；经闭不行多因“脾胃久虚”，经后腹痛及大病后闭经多由于“气血两虚”，由此可随证治之。沈金鳌在《妇科玉尺》^[23]提出月经病脾胃辨证的重要性，“有脾胃伤损者，不尽可作血凝经闭治也”，这就提示我们临床治疗闭经、月经后期等病时，因脾胃损伤者，不能辨为经闭死血，慎用攻伐药，以防伤中气。若脾胃无病，因气滞血瘀，方可活血通经。萧埙《女科经纶·月经门》^[24]提出“调经必先于扶脾保胃”的主张，并有“经行之际，禁用苦寒辛散之剂”的说法。竹林寺僧在《竹林女科证治》^[25]中提出，“形盛多痰气虚，至数月而经始行”，说明脾虚不运，痰湿阻滞胞宫，导致月经不调，本书常以苍术六君子汤或苍附导痰丸治之。

这一时期的医家亦丰富了对月经不调病因病机的认识，认为脾气虚、脾湿不化、肝脾不调、脾肾两虚、脾胃气血两虚、脾阴虚、痰邪阻滞等均是导致月经病的重要因素。

9. 小结

春秋战国时期是月经病从脾胃论治的理论奠基阶段，该理论来源于《黄帝内经》；秦汉时期的张仲景已经开始将其应用于临床，《伤寒论》和《金匱要略》中“顾护脾胃”的思想均有体现，并且首次体现了调理月经病重视脾胃和其他脏腑关系的观点；隋唐时期的巢元方明确提出了月经病重视调脾胃的观点，孙思邈尤其注意顾护“脾胃阳气”，其思想不仅体现在养生保健，也体现在妇科治疗中，这在脾胃学说的发展过程中起到了承上启下的作用；两宋时期妇产科开始独立分科，这一时期陈自明的《妇人大全良方》提出了调理气血、调理肝脾的治疗纲领，现已广泛应用于临床，后来医家在此基础上多有发挥；辽夏金元时期的金元四大家在法宗仲景，在前人基础上从生理、病理、治法各个方面完善了脾胃学说，用于更好的治疗内外妇儿的临床；明清时期各家的医学著作丰富了月经病的治疗，开始系统的论述脾胃和月经病的关系，分析脾和其他脏腑的关系，月经病的病因与治法等。

第二部分 现代文献研究

1. 文献资料与研究方法

1.1 文献资料

1.1.1 资料来源

该部分对现代文献中月经病从脾胃论治的临床资料进行研究。以中国知网为检索途径全面检索 1987 年至 2017 年的现代文献。

1.1.2 文献纳入标准和排除标准

1.1.2.1 文献纳入标准：

- (1) 文献内容属于月经病范畴；
- (2) 文献中涉及的西医病名与其研究中医病一致；
- (3) 文献中月经病的治疗使用的从脾胃论治的方法；
- (4) 文献中收入病案具有明确的诊断、证型和治法治则；
- (5) 文献中如有多篇雷同者，以发表时间最早、论述最全面者为准。

1.1.2.2 文献排除标准：

- (1) 文献不属于月经病的范畴；
- (2) 文献中只有相关理论的探讨；
- (3) 文献中使用中成药治疗，但无具体药物组成；
- (4) 使用中医其他治法：如针灸、推拿、耳穴、穴位注射等；
- (5) 排除文献综述、现代药理及动物实验研究、流行病学研究。

1.1.3 文献筛选及入选情况

通过中国知网检索“月经先期”、“月经后期”、“月经先后无定期”、“月经过多”、“月经过少”、“经期延长”、“经间期出血”、“崩漏”、“闭经”、“痛经”、“经行头痛”、“经行泄泻”、“经行眩晕”、“多囊卵巢综合征”、“高泌乳素血症”、“子宫腺肌病”等主题词，筛选符合标准的现代文献。最终筛选文献 199 篇，涉及月经病 12 种，涉及医案 281 个。

1.2 研究方法

1.2.1 统计方法：

运用 Excel、SPSS24.0 等进行月经病病种、调理脾胃方法的频数统计，然后对文献中出现频数排列前三的方法进行药物频数、药类分析，同时对调理脾胃的三种方法进行药性、药味、归经、聚类分析，总结出月经病从脾胃调理的用药规律，为更好的服务于临床提供可靠依据。

1.2.2 数据的预处理：

1.2.2.1 证候名称的规范：对文献中的使用不同名称但临床意义一样或相近的证型进行同义全并，如脾气虚证、脾虚血亏证，统一为气血两虚证。

1.2.2.2 中药别名、俗称及合并名称的规范：根据《中华人民共和国药典》、《中药学》将纳入研究范围内的中药进行规范化用名。使用中药合并名者，拆开并统一使用规范名，如焦三仙拆分为焦山楂、焦神曲、焦麦芽等；部分中药经过炮制加工后功效相近者，统一使用原药名，如醋香附统一为香附；使用中药别名、俗称者，统一使用规范名，如仙灵脾统一为淫羊藿等。

1.2.2.3 对方剂做到标准化处理：针对一些只有处方名称而没有给出具体中药组成的方剂，基于《方剂学》教材，参考相应病种和相应的证候，找出对应的方剂组成。

2. 研究结果

2.1 月经病从脾胃论治病种统计结果：

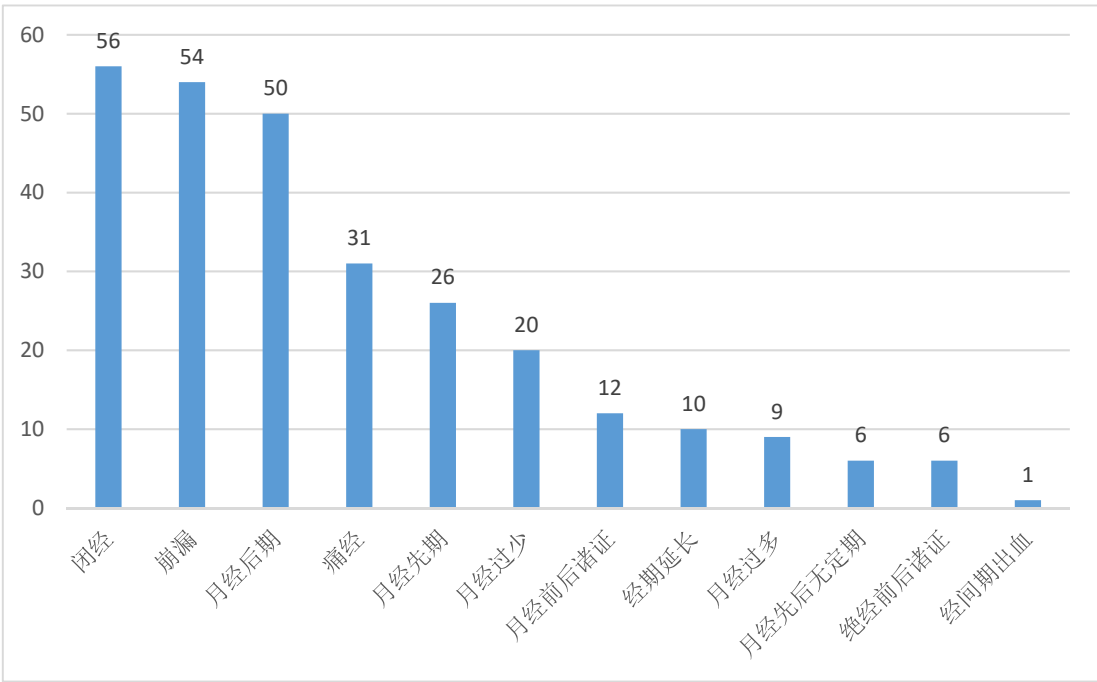


图 1 月经病从脾胃论治病种频数分布柱状图

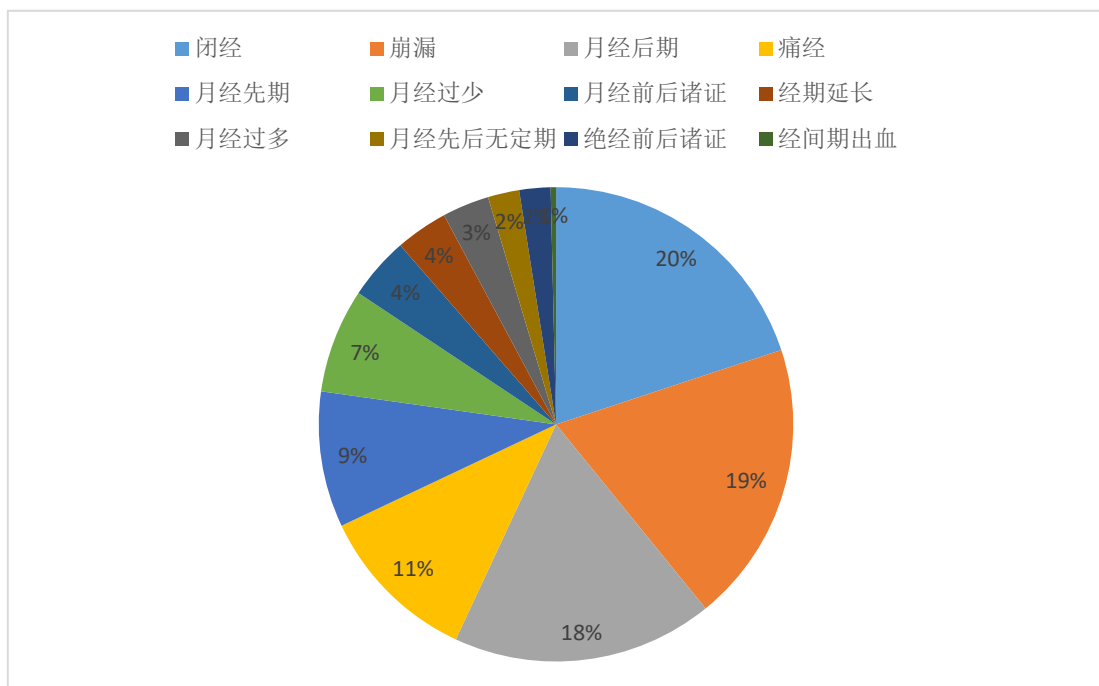
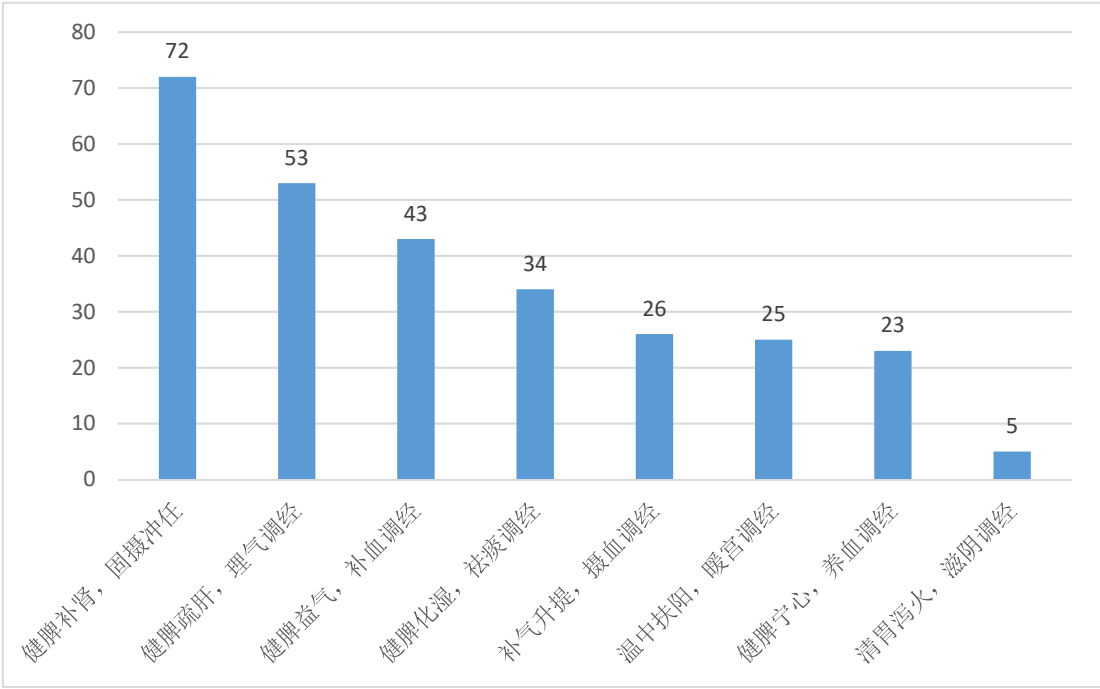


图 2 月经病从脾胃论治病种百分比分布情况

由图 1、图 2 可知月经病从脾胃论治涉及到了 12 种月经病，涵盖了月经病全部病种。各类月经病所占比重从高到低依次为：闭经（20%），崩漏（19%），月经后期（18%），痛经（11%），月经先期（9%），月经过少（7%），月经前后诸证（4%），经期延长（4%），月经过多（3%），月经先后无定期（2%），绝经前后诸证（2%），经间期出血（0%）。

2.2 常用调脾胃法频数统计结果：



（注：上图八种方法是在现代文献搜集整理过程中的总结：脾虚的病机分为气虚，气虚失于统摄，气虚不能生血，阳虚，阳虚不能运化；以及脾与其他脏腑的关系，分为：脾与肾，肝与脾，心与脾，脾和胃）

图 3 常用调脾胃方法的频数统计柱状图

以上八种从方法囊括了全部月经病从脾胃入手的调治原则，由图 3 可知，月经病临床上常用的治法为：健脾补肾，固摄冲任；健脾疏肝，理气调经；健脾益气，补血调经；健脾化湿，祛痰调经；补气升提，摄血调经；温中扶阳，暖宫调经；健脾宁心，养血调经；清胃泻火，滋阴调经。

2.3 八种调理脾胃的方法治疗月经病统计结果：

表 1.（1） 八种调理脾胃方法治疗月经病频数、频率一览表

月经病	健脾益气		补气升提		温中扶阳		健脾化湿	
	补血调经		摄血调经		暖宫调经		祛痰调经	
	频数	频率%	频数	频率%	频数	频率%	频数	频率%
崩漏	12	22.2	12	22.2	1	1.9	2	3.7
月经先期	5	19.2	6	23.0	1	3.8	0	0
闭经	10	17.9	0	0	2	3.6	13	23.2
月经过多	0	0	3	33.3	1	11.1	0	0

月经前后诸证	0	0	0	0	3	25.0	2	16.7
经间期出血	0	0	0	0	0	0	0	0
经期延长	2	20.0	3	30.0	0	0	1	10.0
绝经前后诸证	0	0	1	16.7	0	0	1	16.7
痛经	5	16.1	0	0	11	35.5	2	6.5
月经后期	5	10.0	0	0	2	4.0	11	22.0
月经先后无定期	1	16.7	0	0	1	16.7	0	0
月经过少	3	15.0	1	5.0	3	15.0	2	10.0

表 1. (2) 八种调理脾胃方法治疗月经病频数、频率一览表

月经病	健脾疏肝		健脾补肾		健脾宁心		清胃泻火	
	理气调经		固摄冲任		养血调经		滋阴调经	
	频数	频率%	频数	频率%	频数	频率%	频数	频率%
崩漏	5	9.3	14	25.9	8	14.8	0	0
月经先期	6	23.1	3	11.5	5	19.2	0	0
闭经	10	17.9	15	26.8	3	5.4	3	5.4
月经过多	0	0	2	22.2	3	33.3	0	0
月经前后诸证	4	33.3	1	8.3	2	16.7	0	0
经间期出血	1	100.0	0	0	0	0	0	0
经期延长	3	30.0	1	10.0	0	0	0	0
绝经前后诸证	0	0	3	50.0	1	16.7	0	0
痛经	8	25.8	5	16.1	0	0	0	0
月经后期	9	18.0	20	40.0	1	2.0	2	4.0
月经先后无定期	2	33.3	2	33.3	0	0	0	0
月经过少	5	25.0	6	30.0	0	0	0	0

从上表可看出, 调理脾胃的八种方法在每种月经病的应用因发病机理的不同而有所侧重, 临床以虚证多见。月经先期、月经前后诸证首选方法为健脾疏肝、理气调经; 崩漏、闭经、绝经前后诸证、月经后期、月经先后无定期、月经过少首选方法健脾补

肾，固摄冲任；月经过多、经期延长首选补气升提，摄血调经；痛经首选方法为温中扶阳，暖宫调经。

2.4 调脾胃三法药物频数统计结果：

在所筛选的 281 个医案中，涉及处方 281 个，涉及治法有 8 种，现将使用频数大于 40 次的治法纳入研究范围，分别为：健脾补肾、固摄冲任；健脾疏肝、理气调经；健脾益气、补血调经，以下简称这三种方法为：健脾补肾、健脾疏肝和补益气血。符合健脾补肾法的方剂有 72 个，共应用 156 味中药，累积使用 1036 次，平均使用频次为 6.6 次。符合健脾疏肝法的方剂有 53 个，共应用 140 味中药，累积使用 733 次，平均使用频次为 5.2 次。符合补益气血法的方剂有 43 个，共应用 103 味中药，累积使用 533 次，平均使用频次为 5.2 次。现将三种调理脾胃的方法出现的高频药物列举如下：

表 2 健脾补肾法高频药物统计结果

中药	频数	频率%	药性	药味	归经	药类
白术	47	4.5	温	甘、苦	脾、胃	补气药
当归	44	4.2	温	甘、辛	肝、心、脾	补血药
黄芪	42	4.1	温	甘	脾、肺	补气药
熟地黄	41	4.0	温	甘	肝、肾	补血药
党参	37	3.6	平	甘	脾、肺	补气药
甘草	34	3.3	平	甘	心、肺、脾、胃	补气药
菟丝子	33	3.2	平	辛、甘	肾、肝、脾	补阳药
山药	33	3.2	平	甘	脾、肺、肾	补气药
白芍	33	3.2	寒	苦、酸	肝、脾	补血药
茯苓	31	3.0	平	甘	心、脾、肾	健脾利湿药
川芎	25	2.4	温	辛	肝、胆、心包	活血止痛药
续断	24	2.3	温	苦、辛	肝、肾	补阳药

通过对药物的频数分析，发现频数>5 以上的中药共 53 种，累积出现 837 次，占总频数的 80.8%。上表列举出的为频数前 12 位的高频药物，分别为：白术，当归，黄芪，熟地黄，党参，甘草，菟丝子，山药，白芍，茯苓，川芎，续断。

表 3 健脾疏肝法高频药物统计结果

中药	频数	频率%	药性	药味	归经	药类
白芍	46	6.3	寒	苦、酸	肝、脾	补血药
白术	45	6.1	温	甘、苦	脾、胃	补气药
当归	44	6.0	温	甘、辛	肝、心、脾	补血药
柴胡	42	5.7	寒	苦、辛	肝、胆	升阳药
茯苓	41	5.6	平	甘	心、脾、肾	健脾利湿药
甘草	36	4.9	平	甘	心、肺、脾、胃	补气药
香附	29	4.0	平	辛、苦、甘	肝、脾、三焦	理气药
川芎	25	3.4	温	辛	肝、胆、心包	活血止痛药
益母草	19	2.6	寒	辛、苦	心、肝、膀胱	活血调经药
党参	14	1.9	平	甘	脾、肺	补气药
半夏	12	1.6	温	辛	脾、胃、肺	温化寒痰药
陈皮	12	1.6	温	辛、苦	脾、肺	理气药
栀子	12	1.6	寒	苦	心、肺、三焦	清热泻火药
牡丹皮	12	1.6	寒	苦、辛	心、肝、肾	清热凉血药

通过对药物的频数分析,发现频数>5 以上的中药共 520 次,占总频数的 70.9%。上表列举出的为频数前 12 位的高频药物,分别为:白芍,白术,当归,柴胡,茯苓,甘草,香附,川芎,益母草,党参,半夏,陈皮。

表 4 补益气血法高频药物统计结果

中药	频数	频率%	药性	药味	归经	药类
白术	37	6.9	温	甘、苦	脾、胃	补气药
黄芪	34	6.4	温	甘	脾、肺	补气药
党参	33	6.2	平	甘	脾、肺	补气药
甘草	30	5.6	平	甘	心、肺、脾、胃	补气药
当归	29	5.4	温	甘、辛	肝、心、脾	补血药
白芍	24	4.5	寒	苦、酸	肝、脾	补血药
熟地黄	18	3.4	温	甘	肝、肾	补血药
川芎	16	3.0	温	辛	肝、胆、心包	活血止痛药

茯苓	15	2.8	平	甘	心、脾、肾	健脾利湿药
陈皮	12	2.3	温	辛、苦	脾、肺	理气药
山药	11	2.1	平	甘	脾、肺、肾	补气药
大枣	10	1.9	温	甘	脾、胃、心	补气药
益母草	10	1.9	寒	辛、苦	心、肝、膀胱	活血调经药
升麻	10	1.9	寒	辛、甘	肺、脾、胃、大肠	升阳药

通过对药物的频数分析,发现频数>5 以上的中药共 358 次, 占总频数的 67.2%。上表列举出的为频数前 12 位的高频药物, 分别为: 白术、黄芪、党参、甘草、当归、白芍、熟地黄、川芎、茯苓、陈皮、山药、大枣、益母草、升麻。

2.5 调脾胃三法使用药类频数统计结果:

按照《中药学》将调理脾胃的三种方法用到的全部药物进行药类统计:

表 5 调脾胃三法使用药类频数、频率一览表

健脾补肾法			健脾疏肝法			补益气血法		
药类	频数	频率%	药类	频数	频率%	药类	频数	频率%
补虚药	526	50.8	补虚药	264	36	补虚药	285	53.5
活血化瘀药	104	10	活血化瘀药	114	15.6	活血化瘀药	48	9
理气药	55	5.3	理气药	75	10.2	止血药	41	7.7
利水渗湿药	53	5.1	清热药	67	9.1	解表药	30	5.6
止血药	51	4.9	解表药	66	9	理气药	26	4.9
解表药	49	4.7	利水渗湿药	54	7.4	利水渗湿药	21	3.9
收涩药	49	4.7	化痰止咳平喘药	16	2.2	安神药	19	3.6
清热药	38	3.7	止血药	15	2	清热药	18	3.4
消食药	17	1.6	消食药	15	2	收涩药	11	2.1
祛风湿药	17	1.6	化湿药	13	1.8	温里药	11	2.1
化痰止咳平喘药	16	1.5	安神药	11	1.5	化湿药	7	1.3
安神药	15	1.4	收涩药	7	1	平肝熄风药	6	1.1
化湿药	15	1.4	平肝熄风药	6	0.8	消食药	4	0.8
温里药	13	1.3	祛风湿药	5	0.7	化痰止咳平喘药	4	0.8

平肝熄风药	11	1.1	温里药	5	0.7	祛风湿药	2	0.4
开窍药	5	0.5						
泻下药	1	0.1						
攻毒杀虫止痒药	1	0.1						

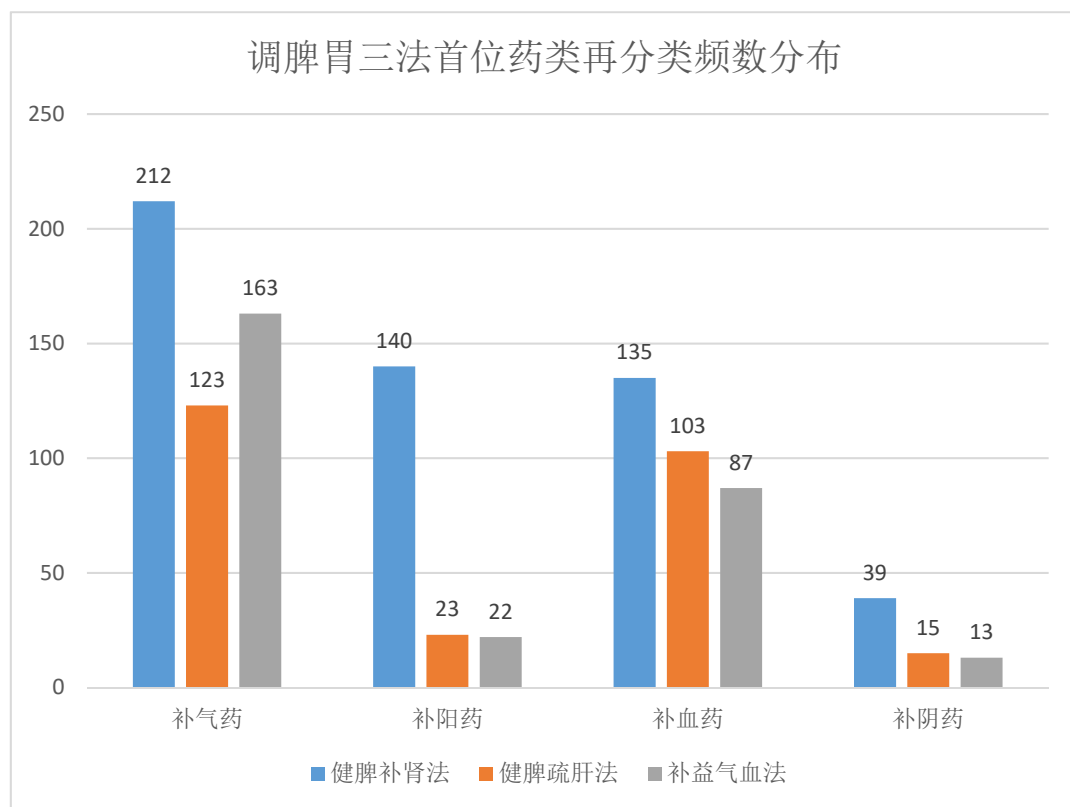


图4 调脾胃三法首位药类再分类频数分布

通过上表可得出结论：调脾胃三法应用最多的药类为补虚药和活血化瘀药。通过上图可得出结论：健脾补肾法应用补虚药的频数由高到低排列为：补气药、补阳药、补血药、补阴药；健脾疏肝法和补益气血法应用补虚药的频数分别为：补气药，补血药，补阳药，补阴药。

2.6 调脾胃三法药性频数统计结果：

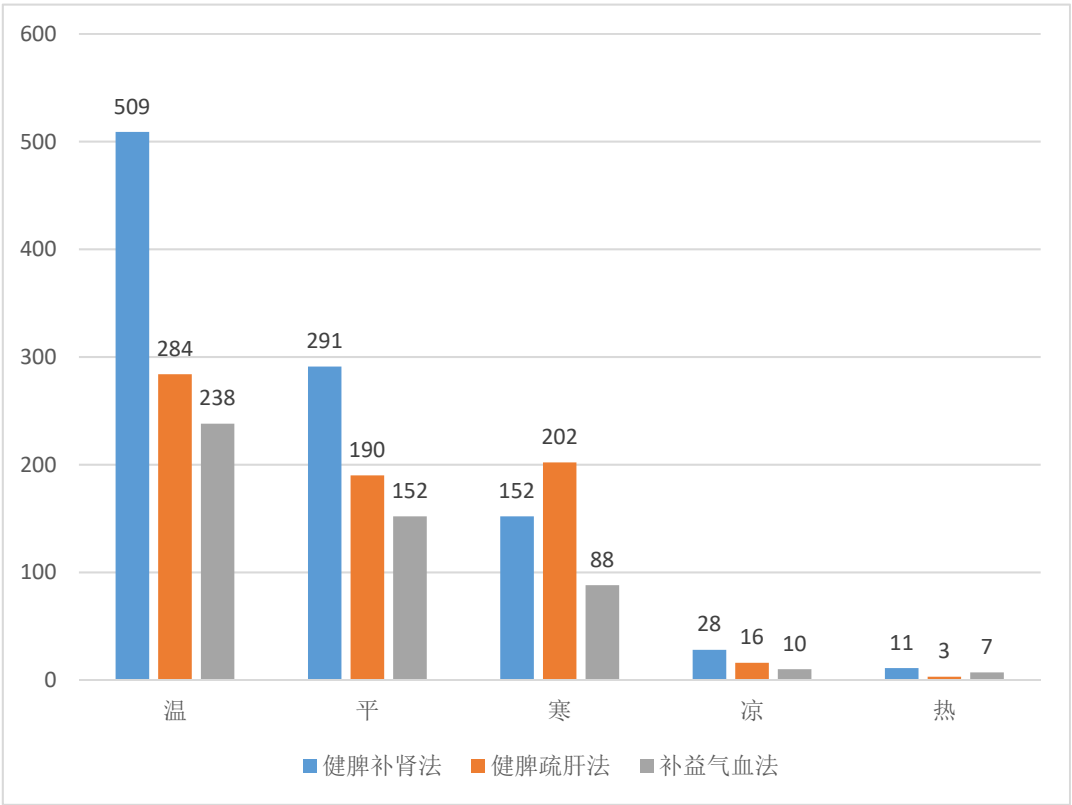


图 5 调脾胃三法药性频数统计结果

由图 5 可总结出，健脾补肾法药性多为温、平、寒；健脾疏肝法为温、寒、平；补益气血法为温、平、寒。

2.7 调脾胃三法药味频数统计结果：

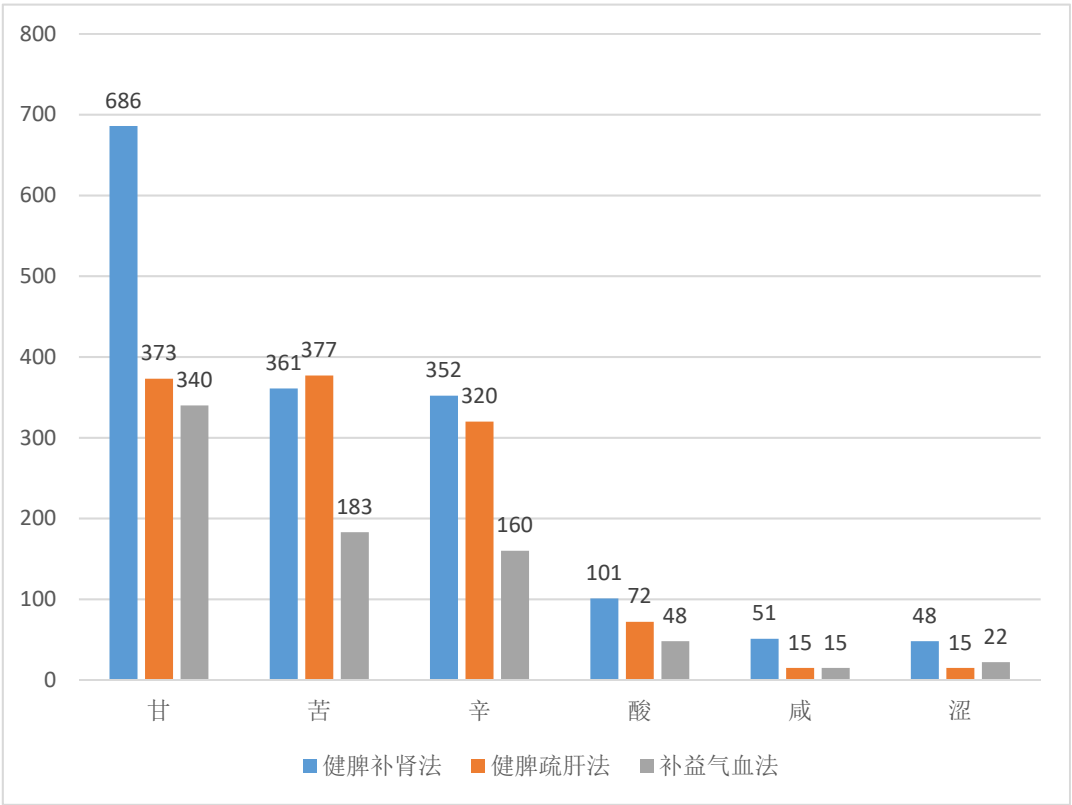


图 6 调脾胃三法药味频数统计结果

由图 6 可知，健脾补肾法的药味以甘、苦、辛为主；健脾疏肝法的药味以苦、甘、辛为主；补益气血法的药味为甘、苦、辛为主。

2.8 调脾胃三法药物归经频数统计结果：

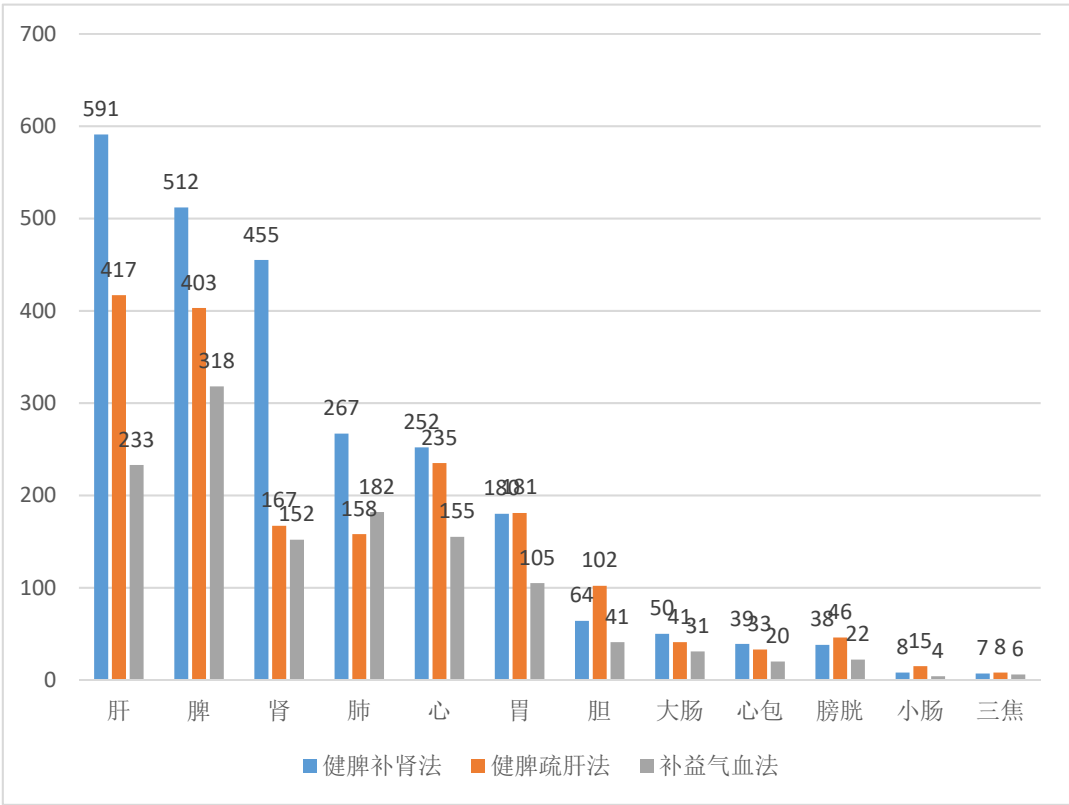


图 7 调脾胃三法药物归经频数统计结果

由图 7 得出结论：健脾补肾法的药物多归肝、脾、肾经；健脾疏肝法的药物多归肝、脾、心经；补益气血法的药物多归脾、肝、肺经。

2.9 调脾胃三法聚类分析结果：

表 6 健脾补肾法聚类药物组合

编号	组成				
A1	熟地黄	当归			
A2	党参	白术			
A3	熟地黄	菟丝子	山药	当归	
A4	熟地黄	菟丝子	党参	白术	当归

表 7 健脾疏肝法聚类药物组合

编号	组成	
B1	白术	白芍
B2	柴胡	茯苓

B3	当归	香附			
B4	白术	当归	白芍	柴胡	茯苓

表 8 补益气血法聚类药物组合

编号	组成				
C1	党参	黄芪			
C2	白术	甘草			
C3	川芎	当归			
C4	党参	黄芪	白术	甘草	
C5	熟地黄	川芎	当归	白芍	

3. 讨论部分

3.1 月经病从脾胃论治的病种讨论

从该部分纳入文献可看出（共纳入文献 199 篇，涉及医案 281 个，参考图 1），现代临床处方中，从脾胃入手调理月经病的方法可调治全部月经病，说明该治法的应用广泛。其中排在前三位的月经病分别为：闭经、崩漏、月经后期，这和临床跟师过程中观察到的月经病的发病率基本一致，这三种病为临床常见病和难治病。月经后期和闭经有着相似的病因病机，均分虚实论治，虚者可因脾虚营血不足，化源不足，血海不能按时满溢，或素体虚弱，先天肾气不足，使得精亏血少；实者可因肝郁气滞或有形痰邪阻滞胞宫。实际临床中实证少见，多虚实夹杂，虚为本，实为标，可由于脾阳不足导致脾胃无以运化痰湿，或由于脾气虚导致不能濡养四肢出现气滞。现代人医学常识的缺乏，使得月经后期得不到应有的重视，日久可衍变为闭经和崩漏。崩漏的发生多由于脾虚不能固摄血液使得血不归经或肾虚不能封藏使得冲任不固，不能制约经血。

肾主生殖，在女子月经正常来潮起着尤为重要的作用。若肾气本虚，先天原本不足，则可以后天补养先天，因此月经病从脾胃入手，可在治疗当中起到增益的效果。

3.2 常用的调理脾胃方法的讨论

夏桂成^[26]对调脾法在妇科的应用体会很深，概括出常用的十种方法：健脾养血法，补脾统血法，健脾利湿法，升清降浊法，温中运脾法，滋阴健脾法，化瘀促运法，培土疏木法，补火暖土法，心脾两调法。郑惠芳^[27]主任医师在妇科病的辨证论治中亦非常重视脾胃，临床当中常用的方法总结为：健脾益气，滋补化源；益气摄血，升阳举

陷；调和脾胃；健脾除湿以及注意脾和其他脏腑的关系。宋莉莉^[28]在自己的临床中将妇科病常用的调理脾胃的方法总结为：补脾升阳法，健脾养血法，益气摄血法，益气化痰法，健脾利湿法，健脾化痰法，健脾调肝法，温补脾肾法，健脾补肺法，健脾养心法。但关于临床中月经病常用的从脾胃调理的方法未有总结，在现代文献收集的过程中发现，月经病以脾的病机为主，多由于脾气虚、脾阳虚、痰湿等，然而常兼夹肝肾的病机，将类似的病机合并，借鉴妇科调脾法的总结以及结合导师从脾胃治疗月经病的经验体会，将月经病调理脾胃的方法总结为八种：健脾补肾，固摄冲任；健脾疏肝，理气调经；健脾益气，补血调经；健脾化湿，祛痰调经；补气升提，摄血调经；温中扶阳，暖宫调经；健脾宁心，养血调经；清胃泻火，滋阴调经。

之所以总结为以上八种方法是从脾胃的功能及脾胃和相关脏腑的关系入手。脾气虚可以导致气虚不能生血，气血两虚，因而治应健脾益气，补血调经；脾气虚导致中气下陷、不能固摄血液，治应补气升提，摄血调经；脾阳不振，中焦虚寒，治应温中扶阳，暖宫调经；脾阳不能运化水湿，导致痰阻中焦，治应健脾化湿，祛痰调经。另外脾肾两虚证当健脾补肾，固摄冲任；肝郁脾虚证当健脾疏肝，理气调经；心脾两虚证当健脾宁心，养血调经；脾胃不和的应当清胃泻火，滋阴调经。

脾胃为脏腑升降出入的枢纽，能够主导气血津液的运行，与其他脏腑的关系十分密切。

3.2.1 脾和肾

肾为先天之本，主藏精；脾胃为后天之本，主运化，主统血，而精能化血，血又能生精，精血能够相互滋生，它们共同为月经提供物质基础。《素问·上古天真论》关于女子七七的论述，说明肾气的盛衰主宰着天癸的至与竭，主宰着冲任流通、经血盈亏，然后《医宗金鉴》亦有言“先天天癸始父母，后天精血水谷生”，说明月经的正常来潮不止需要先天肾气的充盛，同时也需要后天脾胃化生水谷精微。蒋士生^[29]认为，月经病的治疗应注意调理脾肾，脾肾互济，先天得充，后天得养，脾运强健，肾阳旺盛，则冲任盈满，月经如期来潮。因而临床中健脾不忘补肾，补肾同时补脾，或健脾为主，或补肾为先，或脾肾同治，通过调理脾肾达到调理冲任的目的。

3.2.2 脾和肝

女子以肝为先天，肝脾两脏在生理和病理上有着密不可分的关系，肝主疏泄而能藏血，脾主运化而能统血。《傅青主女科》有言“肝气舒自不克土”，脾胃的升降和

纳运功能需要依赖肝气的疏泄和条达，若肝失于疏泄，则横逆脾胃，脾失健运，可导致月经病的发生。现代医学提倡“自然—生物—心理—社会”的医学模式，社会环境的变化，女性压力的增大，使得肝气郁结，血随气结，可出现经前乳房胀痛、痛经、闭经等等月经病。早在《内经》已有肝脾病机的论述，见肝之病，知先传脾，因而古代医家治疗月经病时重视肝脾同调，叶天士在《临证指南医案》指出，逍遥散之所以被奉为圣药，广泛的用于妇科的临床，大概是因为重在调理肝脾两经。李建梅^[30]研究历代文献指出，肝脾失调的病机可出现在妇人一生之中的各个年龄段，肝脾失调常用方剂有：当归芍药散、四逆散、逍遥散、丹栀逍遥散等。

3.2.3 脾和心

《素问·五脏生成篇》指出：“诸血者，皆属于心。”女子经水为血所化，而血受心的调控，心与胞宫借胞脉取得直接联系，正如《素问·评热病论》云：“月事不来者，胞脉闭也；胞脉者，属心而络于胞中。”《素问·阴阳别论篇第七》提出“二阳之病发心脾”的说法，认为肠胃发病，心脾受之，心受之，则血不流，脾受之，则味不化，因而心脾病可导致各种月经病。《女科经论》引虞天民云：“妇人百病皆自心生。”可见，积想于心可导致各种妇科病的产生。李东垣同样认为脾是生化之源，心能统诸经之血，如果心脾平和，则经水能正常来潮，但如果七情内伤、六淫外侵、饮食不节、起居失宜则造成脾胃虚损、心火妄动，继而月经不调。临床中常以归脾汤来治疗心脾两虚型月经病，健脾的同时不忘清心火补养心血。

3.2.4 脾和胃

脾和胃同居中焦，两者互为阴阳，互为表里，是气机升降的枢纽。叶天士在《临证指南医案》中提到“脾胃之病……其于升降二字尤为重要”。脾具备主运化、主升清、统摄血液的功能；胃能受纳，腐熟水谷，被誉为水谷之海，为多气多血之腑。脾气升清，胃气降浊，升降相因，共同构成了脾胃的升降运动，完成对食物的消化、吸收、输布和排泄功能。脾气不升，则气血生化之源不足，胃气不降，则津液留滞，蓄为痰饮。由此可知，调理脾胃的升降功能正常在月经病治疗当中的重要性。

从该部分的研究可看出（参考图2），临床上最常用的月经病从脾胃调理的方法为：健脾补肾，固摄冲任；健脾疏肝，理气调经；健脾益气，补血调经。由此可知最常见到的病因为：脾肾两虚，肝脾不调和气血两虚。其他几种方法均可用到，但用到

的次数相较前面三种方法应用较少。可以认为，月经病以虚为主，大多为先后天不足，夹有实证的病机，常见的为肝郁气滞，导致肝脾不调。

3.3 调理脾胃的方法治疗月经病的讨论

3.3.1 月经病优选调脾胃法

临床中治疗崩漏、闭经、月经后期、月经过少、绝经前后诸证首选的方法为：健脾补肾、固摄冲任；治疗月经先期常用的方法为：补气升提、摄血调经或者健脾疏肝、理气调经；治疗月经过多常用的方法为：补气升提、摄血调经或者健脾宁心、养血调经；治疗月经前后诸证、经间期出血、经期延长首选的方法为：健脾疏肝、理气调经；治疗痛经首选的方法为：温中扶阳、暖宫调经；月经先后无定期常用的方法为：健脾疏肝、理气调经或健脾补肾、固摄冲任。

3.3.2 月经周期和月经量的关系

在文献筛选的过程中发现，月经周期和月经量常常出现对应的关系，月经先期而至常常伴有月经过多，而月经后期而来常可伴有月经过少，这和脾胃功能亦有密切的关系。

由表 1 可知，临床治疗中月经先期和月经过多均可应用补气升提、摄血调经法，健脾补肾、固摄冲任法，健脾宁心、养血调经法，由此可见月经先期和月经过多有着相似的病因病机，多由于脾气虚，脾肾两虚和心脾两虚。而月经后期和月经过少均可应用健脾益气、补血调经法，温中扶阳、暖宫调经法，健脾化湿、祛痰调经法，健脾疏肝、理气调经法，健脾补肾、固摄冲任法，两者共同的病因病机可能是气血不足，中焦虚寒，脾虚痰湿，脾虚肝郁。月经先后无定期的常用治法为：健脾疏肝、理气调经和健脾补肾、固摄冲任。因此，脾虚肝郁和脾肾两虚可导致月经或提前或错后。比较可知，先期量多的病因主要是脾虚，后期量少的病机则在脾虚的基础上出现了夹实的症状，如肝郁和痰湿。总的来说，临床上月经后期的病人多于月经先期的病人，月经过多的病人多于月经过少的病人。

3.3.3 八种方法的应用范围

继续图 1 可看出，调理脾胃的八种方法在每种月经病的应用因发病机理的不同而有所侧重，临床以虚证多见。崩漏、月经先期、月经过多、经期延长病机以脾气虚（气虚不能摄血，气血两虚），脾肾两虚为主，涉及心脾两虚；闭经、月经后期、月经量少涉及痰的病机，以及脾肾两虚，多从健脾化湿祛痰，补益脾肾论治；痛经以寒为主，

温中效果较好；几乎每种月经病均涉及肝脾同调的病机。其他因病案较少，无法对其规律进行总结。

月经后期和闭经有着完全一致的病机和治法，除补气升提、摄血调经的治法，两者临床中可用到其他七种调理脾胃的方法，可见从脾胃论治闭经和月经后期在临床应用广泛。崩漏除清胃泻火、滋阴调经，亦应用了其他七种调理脾胃的方法。这也印证了闭经、月经后期、崩漏临床应用调理脾胃法的广泛性。

3.4 调脾胃三法高频药物讨论

健脾补肾法高频药物分别为：白术，当归，黄芪，熟地黄，党参，甘草，菟丝子，山药，白芍，茯苓，川芎，续断。健脾疏肝法高频药物分别为：白芍，白术，当归，柴胡，茯苓，甘草，香附，川芎，益母草，党参，半夏，陈皮。补益气血法高频药物为：白术、黄芪、党参、甘草、当归、白芍、熟地黄、川芎、茯苓、陈皮、山药、大枣、益母草、升麻。综上，调脾胃三法共涉及 19 味药，这些是调理脾胃的核心用药，历代医家对这些药物的应用有着自己读到的经验，现代药理研究亦能佐证药物的功效：

（1）白术：白术^[31]为“脾脏补气健脾第一要药”，性甘、苦、温，归脾、胃经，此外还能安胎。《傅青主女科》对白术的运用独具匠心，论其“利腰脐”。张林等^[32]探讨了白术在傅氏临床应用特色，对“腰脐理论”做出探讨，认为白术在《傅青主女科》中应用范围广，调经、血崩、种子、妊娠等门均有应用，涉及经、带、胎、产、杂各种疾病，应用频率最广的为血证和痛症。白术在《女科》中常常作为君药，最大可用至一斤。关于白术利腰脐的解释，林峻生^[33]认为，肾属先天火气，在腰的部位；脐属后天母气，先天火气行于脏腑而接于后天母气，腰脐之气除了与脾相互关联，和五脏整体的气机关系密切，这就扩大了白术的应用范围。《傅青主女科》多首方剂，如温脐化湿汤、完带汤、开郁种玉汤等均能体现利腰脐的深刻认识。张林等^[34]认为，利腰脐之气能够通达带脉、升补任督、活血止痛。临床可以通过使用白术，补脾胃而达到利腰脐的目的。

（2）当归：李中梓称其“能引诸血各归其所当归之经”，名为当归，为妇科良药。当归为血中气药，补而不滞，妇人以血为本，故而常有“十方九归”的说法，当归的广泛应用还体现在，当归头止血，当归身养血，当归尾破血，当归生用止血，酒制活血，炒炭止血。当归可应用于治疗各种妇科疾病，如傅青主的固本止崩汤治疗脾

虚崩漏，方中当归配伍黄芪，有当归补血汤之意，功能大补气血。现代药理的研究发现，当归中的多糖能刺激血红蛋白及红细胞的生成，并且能够刺激造血干细胞的生成，促进红细胞的分化，从而促进造血功能^[35-36]。

(3) 黄芪：黄芪为常用补气药，李时珍称其为“补药之长”。金元时期的医家张元素对黄芪的功效作了总结^[37]，认为黄芪甘温纯阳，有五种功效：补诸虚不足，为其一；益元气，为其二；壮脾胃，为其三；长肌肉，为其四；排脓止痛、活血止痛、内托阴疽、为疮家圣药，为其五。严新杰^[38]研究指出，叶天士的《临证指南医案》记载中，处方中运用黄芪最多的主证为气虚总证和阳虚总证。因黄芪这种壮脾胃、补虚的功效，可广泛的应用于月经病脾胃虚弱、气血两虚等证候。

(4) 熟地黄：甘、温，能大补阴血，补益精髓。明代医家张景岳擅用熟地，对此有独到的认识，认为熟地为“精血形质中第一纯厚之药”。郭慧蕾^[39]等通过对《妇人规》中含有熟地的方剂进行整理分析后得出结论，熟地黄能够大补血衰、滋补真阴、厚益脾胃；对熟地配伍应用研究后认为，该药和补药兼用可入五脏，和通剂兼用可调经，和气剂兼用能入气分，和温剂兼用能回阳，和散剂兼用能发汗。可见，熟地黄可配伍多类药物治各类妇科血证和虚证。

(5) 党参：味甘性平，能归脾、肺经。该药实际应用补脾却不燥，养胃却不湿，润肺而不寒凉，养血却不滋腻。现代药理研究^[40]认为，党参能兴奋神经系统，可以增强机体的抵抗能力，能增加红细胞和血红蛋白，可用于缺铁性及营养不良性贫血，还可以健脾祛痰、增进新陈代谢，帮助消化，促进乳糜的吸收。现代药理充分印证了党参补气的功效，以及气能生血的作用。

(6) 甘草：甘草味甘，性平，无毒，为中药当中的“国老”、“药中百搭”，为极普通又常用的中药，但决不是可有可无的“调味品”。《神农本草经》将甘草列为上品，认为甘草多种功效，能缓急止痛、益气通脉、泻火解毒、润肺止咳等，也能调和诸药。甘草和芍药配伍为有名的芍药甘草汤，甘草味甘能益脾，脾胃健运则血气充盈，妇人以血为本，甘草本身便能入血分，芍药和甘草相合，酸甘相合，能合化阴血。尤其是芍药和甘草的配伍，能治妇科肝血不足、筋脉失养所致诸多血证和痛症。

(7) 菟丝子：菟丝子平补肝、脾、肾，能固精缩尿，安胎，补益肝肾，明目，止泻，为妇科临床要药。国医大师朱良春认为，菟丝子是能够阴阳并补，用它来补肾益精，助阴而不膩，温阳而不燥。”《本草正义》谓：“其味微辛，则阴中有阳，守

而能走。”因而菟丝子也被视为补药之中的动药。现代药理研究^[41]表明其具有改善生殖功能、影响骨代谢、延缓衰老、调节免疫系统等作用。

(8) 山药：山药甘、平，能归脾、肺、肾经，通常被认为是药食两用的佳品。而张锡纯不这么以为，他提出“山药之性，能滋阴又能利湿，能滑润又能收涩”，张氏以单味山药煎汁，为一味薯蓣饮，以山药细末煮沸成粥，命名为薯蓣粥，可见山药一味，为滋补良药。孙洋^[42]等通过检索国内关于山药的药理研究的文献等，总结出山药具有增强免疫功能、调节胃肠功能、降低血糖、保肝、延缓衰老、抗肿瘤等功效。

(9) 白芍：《大明本草》言其能治“女人一切病”。清代医家傅青主临床擅用白芍，认为“病之在肝，尤不可不用”。张利^[43]研究白芍的药用成分，得出结论：白芍具有镇痛、镇静、抗惊厥的作用，对急、慢性免疫性炎症均有抑制作用，具备免疫调节功能，能保肝，能改善血液流变学。

(10) 茯苓：茯苓味甘、淡，性平，可用于治疗脾虚食少、便溏泄泻、惊悸失眠、心神不安等症。该药在月经病临床中应用广泛，如千古名方桂枝茯苓丸，配伍茯苓意在健脾渗湿，由于瘀积日久，阻滞水道，导致水湿停聚，茯苓用在这里意为血水同治，临床可用于治疗痛经、闭经、经期延长、崩漏等多种月经不调。茯苓^[44]有保肝、利尿、调节免疫功能、抗氧化、抗肿瘤、抗炎、抗病毒等多种药理作用，在医疗临床当中有很好的应用前景。

(11) 川芎：川芎味辛、性温，上行能治头痛，下行可缓解血瘀气滞，可作为引经药使用。《日华子本草》指出川芎，“治一切风，一切气，一切劳损，一切血”。川芎广泛用于治疗月经病，因其能活血行气止痛，可治痛经；能燥湿止泻，可治经行泄泻；因其能行的特点，可治经行头痛、经行遍身疼痛；因其能治风的特点，可治经行风疹块等等。

(12) 续断：苦、辛，微温，入肝、肾经。《神农本草经》中即有记载：主“补不足”“妇人乳难”，可知此药如其名字，可强肝肾精血、续筋骨断绝，对补益女子月经的生化来源有着重要的作用，唐代名方青娥丸与近代张锡纯的寿胎丸等方都用到续断，于妇科虚证大有裨益。

(13) 柴胡：《神农本草经》言其“主心腹肠胃中结气”“推陈致新”，在《伤寒论》中应用颇为广泛，后世统称作“柴胡剂”。柴胡应春木荣发之意，药性疏达，善入少阳，游于半表半里，可调肝胆气郁等证，是治疗此类月经疾病的要药，如逍遥

散即用之。《滇南本草》也有记载柴胡“治妇人血热烧经，能调月经”，更说明了柴胡解透郁热，调顺气血的功效。

（14）香附：又名“莎草根”，味辛甘，性平，为妇科调气解郁以顺血随经之要药。妇人以肝为先天，而常失于气机郁遏，致使血行不畅，或郁而不发，或离经而溢，导致月经不能按时按量疏泄，形成临床各种月经病，由病影响七情，形成进一步的气血紊乱的恶性循环，故朱丹溪的越鞠丸可解六郁，也常用于月经病中。

（15）益母草：《系辞》有载：“乾道成男，坤道成女”，益母草别名“坤草”，可知此药与妇科疾病之密切。性微寒，味辛苦，有活血祛瘀，调经消水的功效，常用来治疗气血瘀滞而化热致使月经不调，瘀血腹痛，崩中漏下等病证。现代药理研究^[45]表明益母草有双向调节子宫平滑肌的作用，郑劫观察 200 例异常子宫出血患者，应用益母草进行治疗，随访 6 个月，总有效率达到 100%，随访一年总有效率达到 82.5%，可见该药对异常子宫出血有较好的治疗效果。

（16）半夏：性辛温，有毒，入脾、胃、肺经，常与陈皮共用，为燥湿化痰的上好药对，而本身尤擅治疗湿痰为患，如果存在痰湿困脾，湿痰流注的因素，如表现出面色晄白，身体困重，少言懒食，胸膈不舒等症状，可加用之。脾胃为气血生化之源，肺主气朝百脉，若受痰湿所困，不能行其正常功用，月经则来源不足，行止失司，也会出现不调的症状。

（17）陈皮：多入脾、肺二经，味辛能散，苦能燥能泻，温能补能和，故陈皮一味，能燥能宣，有补有泻，可升可降，是理气化痰的要药，正如《本草备要》说陈皮治病的原理：“人身以气为主，气顺湿除，则百病散。”在月经病中，自有痰湿为因的类型，不仅行血没有规律，带下疾病也有明显的色、味、质的异常，黏腻日久不能好转，常用陈皮一类的药物颇为对证。

（18）大枣：大枣甘平质润，能益气和中，润燥缓急。首见于《神农本草经》，“甘平，主心腹邪气，安中养脾，助十二经，平胃气，通九窍，补少气少津，身中不足大惊，四肢重，和百药”。《金匱要略》有著名的方剂甘麦大枣汤，治疗妇人“脏燥”，即更年期综合征，临床应用广泛。此外，大枣常常一药多用，或作为使药出现在方剂中，意为调和诸药。

（19）升麻：《神农本草经》载其“味甘辛”，后世医家认为其性微凉，可升举脾胃之阳气而不助热邪，是气虚下陷的病证中常用的药物，常与疏肝胆气之柴胡同用，

如补中益气汤与升陷汤等都如此组方。病人如果出现气虚症状，内脏气血无力被托举而下陷，正常的气血运行也会由此或缓滞，或郁阻，或不循常道而出，于女子可能会出现月经或量少色淡，或崩而不收的情况。

3.5 调脾胃三法的药类性味归经讨论

从该部分研究可看出，健脾补肾法共应用 18 类中药，健脾疏肝法和补益气血法均应用 15 类中药。这三种调脾胃的方法中药应用首位的均为补虚药，其次为活血化瘀药。这能充分表明临床月经病以虚证为主，其次常见的病机为血瘀。虚者当补，其中健脾补肾法应用补虚药以补气药和补阳药为主，可知脾肾两虚中以阳虚多见，健脾疏肝法和补益气血法均以补气药和补血药为主，可见疏肝亦在调理肝血，女子以血为本，气足血亦足。气虚无力推动血液运行常常导致血瘀，瘀血亦是导致月经不调的另一个重要原因，《黄帝内经》已有“血实者宜决之”的说法，即采用活血化瘀之法治疗月经病实证或虚实夹杂证；张仲景在临床当中创制了抵挡汤、桃核承气汤等方剂，也能体现活血化瘀的大法，此外王清任的五种逐瘀汤常常用于调理月经病的痛症和血证，唐容川在《血证论》中主张祛瘀生新，常用于治疗漏证。此外，脾气虚证临床常用举元煎方常佐以活血化瘀之类，取“瘀血不去，新血不生”之意，妇科常用方剂四物汤佐以川芎使补中有行，补气血而不留瘀滞。由于气和血的关系密不可分，气血亏虚可导致血行瘀滞，因此补虚药最常用于调理妇科月经病，常佐以活血化瘀药如四物汤治疗脾气虚导致的瘀血阻滞。

此外，健脾补肾法药性多为温、平、寒；健脾疏肝法为温、寒、平；补益气血法为温、平、寒，三法均较少使用大热大寒之品，以温为主，合乎妇人特点，属阴，宜温补。健脾补肾法的药味以甘、苦、辛为主；健脾疏肝法的药味以苦、甘、辛为主；补益气血法的药味为甘、苦、辛为主，味甘入脾经，味苦入心经，味辛入肺经，暗合《黄帝内经》之“二阳之病发心脾”、“气上迫肺，心气不得下通”等论述。健脾补肾法的药物多归肝、脾、肾经；健脾疏肝法的药物多归肝、脾、心经；补益气血法的药物多归脾、肝、肺经，这也暗合了前人关于五脏和月经关系的论述，月经的产生和五脏均有关系。

3.6 调脾胃三法的聚类药物组合讨论

此聚类涉及的药物以上均有论述，配伍形成药对后治疗上起到增强药物疗效、扩大药物的应用范围、减少不良反应等作用。以下将调脾胃三法具有代表意义的典型药

对详加分析：

A4 熟地黄，菟丝子，党参，白术，当归：党参、白术健脾，当归补血，熟地黄、菟丝子补肾益精，药对在健脾的基础上加了补肾之品，此组合为健脾补肾法的核心药物。

B4 白术，当归，白芍，柴胡，茯苓：此五味药为千古名方逍遥散（出自《太平惠民和剂局方》）的主药，该方剂在妇科应用范围极广，是专门针对肝郁血虚、脾失健运而研制的。该组合既有柴胡顺肝木条达之性，又有白芍养血柔肝，当归可行气，味甘能缓急，白术、茯苓健脾祛湿，使运化有权，气化有源。赖萍^[46]等人通过给小鼠静推利血平注射液，造成小鼠脾虚消瘦、倦怠乏力的模型，观察小鼠的体重和自主活动次数以及游泳时间长短，最后得出结论逍遥散对脾虚导致的消瘦、倦怠乏力有补益的作用。王静怡^[47]等研究指出，逍遥散有减少运动的作用，能抗慢性抑郁，认为其疏肝理脾的功效和抗焦虑、抗抑郁的作用有关。此组合为健脾疏肝法的代表药对。

C4 党参，黄芪，白术，甘草：此四味药为举元煎的底方，能益气升提，可在此基础上加减治疗气血两虚气虚下陷所导致的崩漏、经期延长、月经先期等。党参、黄芪大补元气，白术健脾，滋血之源，甘草既能补脾气，又能调诸药。李爱君^[48]等观察120例异常子宫出血的患者，治疗组60例予举元煎加味治疗，对照组予口服孕激素或雌激素等药物止血，结果治疗组的疗效优于对照组，两组比较有显著差异($p < 0.01$)。此组合为补益气血法的代表药对。

C5 熟地黄，川芎，当归，白芍：此四味药刚好组成一妇科常用方剂——四物汤。古人认为春生夏长秋收冬藏，为四时万物生长变化的自然规律。而四物汤这恰好体现了人体四季的升降变化。清代医家柯韵柏评价四物“当归甘温和血，川芎辛温活血，芍药酸寒敛血，地黄甘平补血”，把当归比作春日生发之气，川芎比作夏日繁茂之气，白芍比成秋令，地黄味厚为冬令，一首四物包含了生长收藏天地四气，有动有静，滋而不腻，温而不燥，补而不滞，为补血调经的经典组合。沈军^[49]对四物汤的现代临床应用进行了分类和归纳，认为四物汤可用于治疗多种月经病。四物汤主要有效成分包括多糖、苷类、生物酸类、生物碱类、微量元素和挥发油^[50-51]，其药理作用主要体现在多个方面，如对造血系统的作用，能预防纠正贫血；对血液流变学的影响，能抗凝血、抑制血栓形成，改善微循环；能调节内分泌，用以治疗黄体功能不全，月经失调等；作用于子宫平滑肌，具有促进子宫收缩和抑制子宫收缩的双向调节作用；抗自由

基作用，保证红细胞携氧运氧能力，有利于机体的恢复。此组合亦为补益气血的基础方。

3.7 月经病异病同治的讨论

异病同治的观点起源于张仲景的“观其脉证，知犯何逆，随证治之”辨证论治思想，是指不同的疾病在发展转归过程中因为出现了相同的病机从而表现出相同证候，因此可采用相同的治法和方药。如同该部分讨论，临床中不同的月经病，虽然表现的临床症状不同，但因病机相同，辨病识证，谨守病机，均可从脾胃论治。

第二部分 导师典型病案分析

1 健脾补肾法的应用

李某，女，45岁，2017年3月

初诊：

病史：阴道不规则流血16天，劳累后诱发，就诊时流血量已不多，色淡红，少量血块，腰酸。既往月经无规律，7天/1-2月，经量少。白带量不多。体型偏瘦，面色萎黄，平常饮食欠佳，眠差，大便稀薄，小便可。

舌脉：舌质淡、苔薄白，脉细弱无力。

诊断：崩漏；月经后期

辨证：脾肾两虚证

分析：分析患者诸多症状，患者为脾肾两虚，脾虚气陷，不能统摄血液，冲任失故，不能制约经血，发为崩漏，由于平素肾虚，导致月经量少，后期而至，腰酸等症状。

治法：健脾补肾，固摄冲任

方药：安老汤加减

党参30g，黄芪30g，熟地30g，白术15g，
枸杞子10g，荆芥炭12g，木耳炭12g，煅牡蛎30g，
生甘草6g。

7剂，水煎服，日两次。

复诊：

主诉：服药3天后血止，腰酸症状改善。

处方：上方去荆芥炭、木耳炭。加升麻6g，当归12g，阿胶11g（烊化）。

14剂，水煎服，日两次。

三诊：

主诉：服药期间未出现阴道流血，已无腰酸，食欲改善。

处方：上方继用。

7 剂，水煎服，日两次。

按语：崩漏为妇科常见病，亦为疑难杂症。导师认为此病和体质有关，从体型、面色、饮食可见该病人素体脾虚，气血化源不足，月经常常后期而至。因平素月经量少，月经延后，经期常伴有腰酸可知该病人亦有肾虚表现。安老汤加减变化可用于崩漏出血期的止血，亦可用于血止后的澄源复旧。安老汤方中党参、黄芪、白术健脾益气，熟地、阿胶滋肾壮水，当归、枸杞子养血补肾固经，木耳炭活血止血，甘草调和诸药。全方具有补益脾肾、固养冲任的功效。临床脾肾双补，如此调理可致经期如常。

2 健脾疏肝法的应用

宋某，女，25 岁，2017 年 4 月

初诊：

病史：月经周期无规律 2 年，5/半月-4 月。平素工作劳累，心烦易怒，脾气暴躁，焦虑，情绪低落。既往月经规律，7 天/30 天，经量少，色黯，少量血块，经行腹痛。白带量少。纳差，失眠，大便干，小便可。未婚，否认性生活史。

舌脉：舌质暗、苔薄白，脉弦重取无力。

诊断：月经后期；痛经

辨证：肝郁脾虚化热

分析：分析患者诸多症状，患者 25 岁月经无规律，工作劳累，心烦易怒，脾气暴躁，大便干等说明肝郁化热，五行制化提示肝木过旺克脾土，因而有纳差等表现。既往月经量色素质可以佐证辨证。

治法：健脾疏肝，养阴清热

方药：丹栀逍遥散加减

牡丹皮 10g，栀子 10g，当归 12g，白芍 12g，
茯苓 12g，炒白术 12g，生地黄 18g，柴胡 9g，
甘草 6g，薄荷 6g，浮小麦 15g。

7 剂，水煎服，日两次。

复诊：

主诉：服药 7 剂，失眠症状改善。

处方：上方继用。

14 剂，水煎服，日两次。

三诊：

主诉：服药期间易怒症状改善，食欲好转。

处方：丹栀逍遥丸、六味地黄丸缓治。

每日三次，每次 8 粒，温开水送服。

按语：现代人压力大，工作劳累，常常影响女性的生活质量。月经常常不能如期而至，说明此病属本虚，然发病之时诸多症状表现常常以肝火上炎克制脾土导致肝郁脾虚，因此在治疗上可先以汤药缓解不适症状，而后再以丸药滋补肾阴，疏肝健脾缓治。

3 补益气血法的应用

王某，女，38 岁，2017 年 5 月

初诊：

病史：经行腹痛进行性加重 2 年。平素月经规律，5/32d，量少，色黑，少量血块，经行腹痛渐进性加重。白带量略多，淡黄色，无异味，无阴痒。平素头晕心悸，神疲乏力。纳眠可，大便偏干，小便调。

舌脉：舌质紫暗，苔薄白，脉细无力。

B 超：子宫腺肌病

诊断：痛经

辨证：气血两虚夹瘀

分析：分析患者月经量偏少，平素头晕、乏力等临床表现知其素体本虚，气血不足，然其行经之时仍有血块，知瘀血阻滞冲任，因此辨为气血两虚夹瘀证。

治法：补气养血，化瘀调经

方药：八珍汤加减

醋香附 12g，鸡血藤 15g，甘草 6g，续断 15g，
山药 15g，茯苓 12g，麸炒白术 12g，党参 15g，
川芎 12g，当归 12g，白芍 12g，熟地 12g。

7 剂，水煎服，日两次。

二诊：

主诉：服药 5 付后月经来潮，疼痛稍减，月经第三天，仍有血块。

处方：上方改白芍 18g，加五灵脂 9g，醋延胡索 12g，桃仁 12g，红花 12g。

5 剂，水煎服，日两次。

三诊：

主诉：服药 4 剂后血止，仍轻微腹痛。

处方：上方去五灵脂，醋延胡索。

14 剂，水煎服，日两次。

按语：痛经辨证有虚有实，此病人为虚实夹杂，本虚标实。病人 38 岁，痛经进行性加重，因此已非原发性痛经，原发性痛经临床常以经前 3 天服药至经行 3-4 天，而此为继发性痛经，经期活血止痛的基础治标，平时应补气养血以治本。气血本来不足，经行之后，血海更虚，子宫、冲任失于濡养，故而疼痛进行性加重，气血两虚血海未满而溢，因而出现月经量少的表现，头晕心悸、神疲乏力均为气血不足的表现。导师临床注重辨病和辨证相结合。临床常以八珍汤加减，补益脾胃气血，加鸡血藤意在活血化瘀补血，香附为血中气药，气行血行，气帅血行，则瘀血自化，同时不忘加续断、熟地顾护补肾，因日久病可及肾，此为预培其损。

结 语

论文第一部分探索了月经病从脾胃论治的历史发展沿革，总结各个历史时期代表医家的学术思想及理论经验。

论文第二部分对现代文献的检索总结得出，临床中常用的调脾胃的治法有八种，涵盖了脾的病机及与脏腑间的关系，出现频次前三位的治法为：健脾补肾、健脾疏肝和补益气血。脾是月经病中一大病机，常见的有脾气虚、脾阳虚以及脾湿，然而临床中兼有其他脏腑病变的更为多见。该部分只进行了最常用的三种方法的研究，对脾病的病机及用药规律有待进一步挖掘整理，亦只研究了其中的高频药物，不能代表全部的组方规律，对于挖掘制定新方有一定的局限性。

论文第三部分选取了导师临床效果较好的病例进行研究，具备疗前疗后的对比，验证了月经病从脾胃论治的疗效。

参考文献

- [1]王冰. 黄帝内经素问. 中华医典[CD]. 长沙:湖南电子音像出版社, 2006 年.
- [2]张景岳. 类经. 中华医典[CD]. 长沙:湖南电子音像出版社, 2006 年.
- [3]张仲景. 伤寒论. 中华医典[CD]. 长沙:湖南电子音像出版社, 2006 年.
- [4]张仲景. 金匱要略. 中华医典[CD]. 长沙:湖南电子音像出版社, 2006 年.
- [5]王叔和. 脉经. 中华医典[CD]. 长沙:湖南电子音像出版社, 2006 年.
- [6]巢元方. 诸病源候论. 中华医典[CD]. 长沙:湖南电子音像出版社, 2006 年.
- [7]孙思邈. 千金方. 中华医典[CD]. 长沙:湖南电子音像出版社, 2006 年.
- [8]陈自明. 妇人大全良方. 中华医典[CD]. 长沙:湖南电子音像出版社, 2006 年.
- [9]刘完素. 素问玄机原病式. 中华医典[CD]. 长沙:湖南电子音像出版社, 2006 年.
- [10]张从正. 儒门事亲. 中华医典[CD]. 长沙:湖南电子音像出版社, 2006 年.
- [11]张元素. 医学启源. 中华医典[CD]. 长沙:湖南电子音像出版社, 2006 年.
- [12]李杲. 脾胃论. 中华医典[CD]. 长沙:湖南电子音像出版社, 2006 年.
- [13]朱丹溪. 丹溪心法. 中华医典[CD]. 长沙:湖南电子音像出版社, 2006 年.
- [14]朱丹溪. 丹溪手镜. 中华医典[CD]. 长沙:湖南电子音像出版社, 2006 年.
- [15]江瓘. 名医类案. 中华医典[CD]. 长沙:湖南电子音像出版社, 2006 年.
- [16]薛己. 女科撮要. 中华医典[CD]. 长沙:湖南电子音像出版社, 2006 年.
- [17]万全. 万氏女科. 中华医典[CD]. 长沙:湖南电子音像出版社, 2006 年.
- [18]龚廷贤. 寿世保元. 中华医典[CD]. 长沙:湖南电子音像出版社, 2006 年.
- [19]张介宾. 景岳全书. 中华医典[CD]. 长沙:湖南电子音像出版社, 2006 年.
- [20]武之望. 济阴纲目. 中华医典[CD]. 长沙:湖南电子音像出版社, 2006 年.
- [21]傅山. 傅青主女科. 中华医典[CD]. 长沙:湖南电子音像出版社, 2006 年.
- [22]冯兆张. 女科精要. 中华医典[CD]. 长沙:湖南电子音像出版社, 2006 年.
- [23]沈金鳌在. 妇科玉尺. 中华医典[CD]. 长沙:湖南电子音像出版社, 2006 年.
- [24]萧埙. 女科经纶. 中华医典[CD]. 长沙:湖南电子音像出版社, 2006 年.
- [25]竹林寺僧. 竹林女科证治. 中华医典[CD]. 长沙:湖南电子音像出版社, 2006 年.

- [26]夏桂成. 妇科调脾十法[J]. 广西中医药. 1988, 11(5):21-23.
- [27]叶青. 郑惠芳从脾论治妇科病经验[J]. 山东中医杂志. 1992, 11(4):40-41.
- [28]宋莉莉. 妇科病从脾论治十法[J]. 浙江中医学院学报. 1994, 18(1):7-8.
- [29]李慧, 王红梅, 黄亚娟等. 蒋士生从脾肾论治月经病经验[J]. 湖南中医杂志. 2013, 29(8):23-24.
- [30]李建梅. 妇人病肝脾失调证治规律研究[D]. 云南:云南中医学院, 2017.
- [31]高学敏. 中药学[M]. 北京:中国中医药出版社, 2007:429.
- [32]张林, 吴晓丹, 白晶等. 探析《傅青主女科》白术“利腰脐”之用[J]. 中华中医药杂志. 2012, 27(10):2679-2680.
- [33]林峻生. 《傅青主女科》用药特色及组方规律初探[D]. 北京:北京中医药大学, 2009:18.
- [34]龙全江, 徐茂保, 赵海鹰. 当归油炒前后挥发油化学成分对比研究[J]. 中国中药杂志, 2007, 31(24):2085-2087.
- [35]祁晶. 当归多糖的结构分析及其对大鼠复发性阿弗他溃疡模型影响的研究[D]. 兰州:兰州大学, 2011:98-99.
- [36]刘雪东. 当归 CO₂超临界萃取物保护血管内皮细胞的物质基础研究[D]. 南京:南京中医药大学, 2010:45-47.
- [37]张星华. 黄芪应用的历史沿革[J]. 江西中医药, 2008, 39(302):43.
- [38]严新杰. 《临证指南医案》黄芪运用的研究[D]. 广州:广州中医药大学, 2009.
- [39]郭慧蕾, 马红. 论熟地黄在《妇人规》中的应用[J]. 辽宁中医杂志, 2011, 38(9):1782-1784.
- [40]宁理文, 赵红新. 党参的药理作用及临床应用[J]. 临床合理用药, 2014, 7(10):66.
- [41]夏卉芳. 菟丝子的药理研究进展[J]. 现代医药卫生. 2012, 28(3):402.
- [42]孙洋, 梅伦方. 山药药理作用研究进展[J]. 亚太传统医药. 2013, 9(3):50-51.
- [43]张利. 白芍的药理作用及现代研究进展[J]. 中医临床研究. 2014, 6(29):25-26.
- [44]梁学清, 李丹丹, 黄忠威. 茯苓药理作用研究进展[J]. 河南科技大学学报(医学版). 2012, 30(2):154-155.

- [45] 郑劼. 益母草的药用作用及妇科临床的应用研究[J]. 中外医学研究. 2016, 14(3):107-108.
- [46] 赖萍, 陈振念, 卫奕荣. 逍遥散健脾补虚的药理研究[J]. 吉林医学. 2011, 32(13):2614-2615.
- [47] 王静怡, 石玉琨, 查鹏洲等. 逍遥散的药理研究[J]. 中国医院药学杂志. 2002, 22(8):489-490.
- [48] 李爱君, 纪再生. 举元煎加减治疗功能性子宫出血[J]. 现代中西医结合杂志. 2012, 21(20):2202-2203.
- [49] 沈军. 四物汤治疗月经不调研究进展[D]. 北京:北京中医药大学:2008.
- [50] 倪慕云, 边宝林. 地黄化学成分的研究概况[J]. 中国中药杂志, 1989, 14(7):425-427.
- [51] 刘琳娜, 梅其炳, 程建峰. 当归挥发油研究进展[J]. 中成药, 2002, 24(8):621-623.

综 述

月经病从脾胃论治的概述

摘要：查阅总结各种月经病从脾胃论治的现代文献，对临床常见月经病病种从脾胃调治的具体应用作一概述，为今后临床异病同治治疗月经病提供理论指导和临床参考。

关键词：月经病；脾胃

月经病被称为“妇科病之首”，妇人以血为本，血是产生月经的物质基础，而血又来源于脾胃。《女科经纶》有云，妇人的乳汁和经血，都是由脾胃化生而来的。此外，还主张月经病调理脾胃才是最主要的。可见脾胃在妇科月经病治疗中不容小觑的地位。现代人快节奏的生活方式，常常使得脾胃有伤，则经不调。平素饮食不节，过食寒凉、辛辣、刺激等，熬夜，劳累过度均可导致脾阳受损、中土亏虚，导致各种月经病的产生。因此，月经病从脾胃入手调理，常常取得令人满意的效果。下文将调脾胃的方法在临床月经病中的应用进行论述总结：

1. 月经先期

月经先期^[1]主要的病因病机可归纳为气虚和血热，其中气虚又包括脾气虚和肾气虚。陈仁华等^[2]认为其中导致月经先期的脾气虚又可分为中气虚弱和心脾两虚，陈仁华在临床观察的 124 例月经先期患者中，有 12 例属于中气虚弱型，治以补中益气汤，8 例有效。

韩鸿雁^[3]等观察 34 例归脾汤为主方加减治疗少女月经先期的病例，总有效率可达 94.1%，如此可以证实归脾汤治疗心脾两虚型月经先期的具体疗效。说明只要辨证准确，均有治愈的可能。

2. 月经后期、闭经

由于月经后期、闭经的^[4]辨证均分虚实，这里作统一论述。《陈素庵妇科补解·经水后期方论》说“妇人经水后期而至者，血虚也。”由此可见，脾胃虚弱，气血乏源，是导致月经后期的一个因素。《罗氏会约医镜·经脉门》提示“凡血寒血虚者，

俱后期。”可见中焦虚寒，脾阳不足，可影响月经的正常来潮。早在《黄帝内经》就已提出“二阳之病发心脾”，阳明胃病，心脾两虚可导致闭经。《万病回春·调经》认为“经水过期而来，色淡者，痰多也”可见实邪阻滞，痰郁中焦也可导致月经不能如期而至。临床上以虚证为主，常伴有痰湿之邪阻滞。

林素珊^[5]临床观察 35 例脾肾阳虚的月经后期患者，最短病程 3 个月，最长病程 2 年，使用温经汤治疗，发现月经周期长、经量少、畏寒肢冷等脾肾阳虚的症状均有改善，同时能有效缩短基础体温低温相的时间，总有效率可达 94.4%。施燕^[6]临床观察了 63 例非器质性闭经的患者，采用归脾汤加减治疗，总有效率达到了 92.1%。闭经亦不乏从太阴脾土论治的个案，费国斌^[7]曾治一闭经，开始从调肾入手，效果欠佳，思考内经“二阳之病发心脾”，考虑从脾入手，兼顾心肾，用以张锡纯的资生通脉汤（生炒白术、菟丝子、山药、鸡内金、香附、山萸肉、桂枝、龙眼肉、玄参、白芍、桃仁、红花、甘草、附子、白芥子），疗效显著。

3. 月经先后无定期

高晓冉^[8]对月经先后无定期的病证进行初步的文献研究整理，统计结果显示，涉及的证型有：肝郁证、肾虚证、脾虚证、血瘀证、肝郁兼肾虚证、血虚证、肾虚兼肝郁证、肝郁兼脾虚证、血热证、肝肾不足证、湿热下注证、脾虚兼肝郁证、阴虚内热证，为临床从脾胃调理该病提供理论支持。

张少聪^[9]治一月经先后无定期的病人，辨证为肝郁脾虚，方用逍遥散加减，停药后月经按期而至。田淑霄^[10]认为，脾胃虚寒，化源不足，故而月经后期而至，脾胃虚寒，统摄无力，因此月经先期而来，临床用参苓白术散加减治疗脾胃虚寒所致的月经或提前或错后，疗效可。

4. 月经过多、经期延长

月经过多、经期延长^[11]主要的病机为虚、热和瘀。素体虚弱、饮食不洁、过食油腻、思虑过度均可损伤脾气，使得中气不足，不能统摄血液，冲任失约，经量增多。久而久之，气血两虚，又可导致心脾两虚，久病及肾，脾肾两虚。

韩永梅^[12]临床用加味固本之崩汤（黄芪、党参、白术、升麻、柴胡、益母草、泽兰、仙鹤草、地榆、姜炭、熟地黄、炙甘草）治疗脾虚月经过多 50 例，连用 3 个月

经周期观察疗效,显效 20%,总有效率高达 94%。李文艳^[13]治疗 56 例经期延长的病人,服完带汤加味,1-2 个疗程内月经正常的有 38 例,有 15 例在服药 2-4 个疗程后恢复正常,总的有效率达到 94.6%,可见完带汤加减治疗脾肾两虚型经期延长的疗效较好。

5. 月经过少

此病发病有虚有实,虚为肾虚、血虚;实为血瘀、痰湿。林晓华等^[14]人对月经过少的中医证候进行聚类分析发现,月经过少证候分布特点为:肾虚血瘀证>肾虚肝郁证>气滞血瘀证>肝郁脾虚证>脾肾阳虚证。

娄亚敏^[15]观察 60 例女性患者,使用逍遥散加减口服治疗,连续服用三个月经周期,观察结果显示总有效率达到 98.33%,月经量少的症状明显改善。治疗前后的激素水平(FSH、LH、E₂、PRL)无明显差异($p<0.05$),治疗后的子宫内膜较前明显增厚,有显著性差异($p>0.05$)。

6. 经间期出血

吴玉霞^[16]总结古代文献经间期出血的病因病机,临床大致可分为五种:肾阴虚、湿热、脾气虚、血瘀、肝郁,并观察自拟健脾益气祛瘀方(白术、黄芪、党参、熟地、陈皮、茯苓、炮姜、艾叶、阿胶、炒蒲黄、益母草、炙甘草)治疗 65 例经间期出血的患者,患者前后止血效果总有效率为 92.31%。汤传梅^[17]临床观察 64 例经间期出血的患者,随机分成观察组和对照组,观察组用逍遥散加减治疗,对照组口服黄体酮止血,连续观察了 3 个疗程,结果治疗后观察组的总有效率为 93.75%,明显高于对照组 75%,差异具有统计学意义($p<0.05$)。

7. 崩漏

该病^[18]主要病机为冲任损伤,不能制约经血。病因可以概括为虚、热、瘀,虚分为脾虚和肾虚,临床大多为本虚标实。

叶慧宁^[19]观察 108 例脾虚型崩漏的患者,观察组 66 名患者,给予中药补中益气汤治疗,观察组 42 例病人,给以炔诺酮片治疗,结果治疗组的总有效率达 90.91%,对照组为 78.60%,两组比较差异有显著意义($p<0.05$)。林素英^[20]用归脾汤治疗崩漏病人 42 人,总有效率为 86%。张良英教授^[21]认为,崩漏的发病和脾肾二脏的功能是否正常有关系,脾统血,主中气,肾主封藏,若脾肾失常,则经血失约,发为崩漏,因而临床常以自拟的止崩 I 号方加减崩漏出血期的治疗,止血效果好,疗效能达到 95.6%,方中以健脾补肾药物为主。

8. 痛经

痛经^[22]的病机为“不通则痛”和“不荣则痛”，不通分为气滞血瘀、寒凝血瘀和湿热瘀阻，不荣分为气血虚弱和肾气亏损。痛经多虚实夹杂，若经前、经期冒雨涉水，久居阴湿之地，或过食寒凉，可导致中焦虚寒，寒气凝滞发为痛经。痛经亦分寒热，临床以寒证居多。

苏健等^[23]临床观察 60 例脾虚血瘀型子宫腺肌病患者，分为治疗组和对照组，治疗组使用健脾益气活血化瘀的中药治疗，对照组使用西药达那唑对照，结果治疗组疗效显著。翁逸群等^[24]观察 81 例痛经病人，用当归芍药散加减治疗，有效率为 95.06%，说明当归芍药散可用于治疗肝脾不和型痛经。陈莹^[25]认为脾肾阳虚血瘀型原发性痛经，为虚实夹杂之证，常以自拟经痛方治疗，方剂组成为：白芍、延胡索、巴戟天、菟丝子、白术、蒲黄、没药、牛膝、川芎、桂枝、鹿角霜、荔枝核、炙甘草，疗效显著。

9. 月经前后诸证

月经前后诸证^[26]指于行经前后或行经期间，周期性出现明显不适的全身或局部症状，西医又称作经前期综合征。

陈武彦^[27]临床研究发现，理中汤能有效改善脾虚型经行泄泻患者的不适症状，该病多由脾气虚弱、脾肾两虚、肝旺克脾所致，虽然涉及肝、肾的病机，但从脾入手调理中焦，恢复脾胃升降功能，效果良好。王秀霞^[28]认为经行口糜不能一概以火论，临床常以脾肾论治，处方以健脾补肾药，辨证精准，治疗效果好。

10. 绝经前后诸证

该病^[29]指女性绝经前后，围绕着月经紊乱或绝经出现的不适症状，诸如烘热汗出、烦躁易怒、心悸失眠、潮热面红、眩晕耳鸣等。最根本的病机多由于肾的阴阳两虚，然先天之精需要后天水谷之气的充养才能维持其功能。“五七阳明脉衰”，脾胃的衰弱，气血生化之源不足，最终会影响到肾及冲任二脉，因此绝经期女性的诸多不适可从调理脾胃入手。

张佩霞^[30]观察 59 例绝经前后诸证病人，以丹栀逍遥散加味合六味地黄丸治疗，比较前后症状的改善，结果治愈 21 例，好转 34 例，总有效率为 93.2%，丹栀逍遥散疏肝理脾，配六味地黄丸补肾之虚，因此达到治疗的目的。

11. 小结

综上所述, 月经病虽然临床症状不一, 但因其相似的病因病机, 可予同样的治法。随着人们生活水平的提高, 饮食偏于肥甘厚腻, 很少见到因为饮食偏少或者营养不良, 反而出现因为过食油腻、缺乏锻炼、思虑过度, 使得现代女性脾虚的越来越多, 西医对此常常束手无策, 由此月经病从脾胃论治越来越引起人们的重视。调脾胃的方法可总结为常用的健脾补肾法、健脾疏肝法等, 涉及的多首常用方剂如归脾汤、逍遥散、完带汤、参苓白术散、资生通脉汤、温经汤等。这就证实了月经病从脾胃论治疗效确切, 证实了该法在妇科临床应用的意义。

参考文献:

- [1] 张玉珍. 中医妇科学[M]. 北京:中国中医药出版社, 2013:71.
- [2] 陈仁华, 钟兴明. 辨证分型治疗月经先期 124 例[J]. 黑龙江中医药. 2009, 5:25-27.
- [3] 韩鸿雁, 陶艳玲, 袁丽颖. 归脾汤加减治疗少女月经先期 34 例[J]. 长春中医药大学学报. 2009, 25 (3) :402.
- [4] 张玉珍. 中医妇科学[M]. 北京:中国中医药出版社, 2013:77.
- [5] 林素珊. 温经汤治疗脾肾阳虚型月经后期的临床疗效观察[D]. 南京:南京中医药大学, 2009.
- [6] 施燕. 归脾汤加减治疗功能性继发 63 例[J]. 江苏中医药. 2004, 26 (6) :34.
- [7] 费国斌. 闭经从太阴脾土治疗验案一则[J]. 实用中医药杂志, 2000, 4:16 (4) :38.
- [8] 高晓冉. 月经先后无定期证候分布规律的研究[D]. 河北:河北医科大学, 2015.
- [9] 张少聪. 逍遥散化裁治疗月经病临床病例举隅[J]. 世界中西医结合杂志. 2009, 4 (2) :132-133.
- [10] 王菊素, 刘红. 田淑霄老师以脾论治月经病经验[J]. 河北中医. 2007, 29 (8) :678.
- [11] 张玉珍. 中医妇科学[M]. 北京:中国中医药出版社, 2013:88.
- [12] 韩永梅. 加味固本止崩汤治疗月经过多 50 例[J]. 中国中医药科技. 2014, 21 (2) :193.
- [13] 李文艳. 完带汤治疗经期延长 56 例[J]. 四川中医. 2001, 19 (3) :55-56.
- [14] 林晓华, 金哲, 于妍妍等. 基于聚类分析的月经过少中医证候研究[J]. 北京中医药大学学报. 2012, 35 (12) :862-864.
- [15] 姜亚敏. 逍遥散加减治疗肝郁脾虚型月经过少的临床观察[D]. 黑龙江:黑龙江中

医药大学, 2017.

[16] 吴玉霞. 健脾益气祛瘀方治疗脾气虚型经间期出血临床疗效观察[D]. 湖北: 湖北中医药大学, 2013.

[17] 汤传梅. 逍遥散化裁治疗肝郁脾虚型经间期出血临床研究[J]. 亚太传统医药. 2017, 13(18):153-154.

[18] 张玉珍. 中医妇科学[M]. 北京: 中国中医药出版社, 2013:107.

[19] 叶慧宁. 补中益气汤治疗脾虚型崩漏 66 例[J]. 新中医. 2005, 37(8):76-77.

[20] 林素英. 归脾汤加减治崩漏 42 例[J]. 江苏中医. 1996, 17(10):26.

[21] 卜德艳, 姜丽娟, 赵文芳. 张良英教授止崩 I 号治疗脾肾两虚型崩漏止血疗效观察[J]. 云南中医学院学报. 2011, 34(6):35-37.

[22] 张玉珍. 中医妇科学[M]. 北京: 中国中医药出版社, 2013:131.

[23] 苏健, 田李军. 从脾论治子宫腺肌病继发痛经的临床观察[J]. 四川中医. 2013, 31(6):115-116.

[24] 翁逸群. 当归芍药散加减治疗肝脾失和痛经 81 例临床观察[J]. 浙江中医药大学学报. 2014, 38(5):584-586.

[25] 田雨璐, 陈莹. 陈莹分期辨证论治脾肾阳虚血瘀型痛经[J]. 实用中医内科杂志. 2015, 29(6):15-17.

[26] 张玉珍. 中医妇科学[M]. 北京: 中国中医药出版社, 2013:143.

[27] 陈武彦. 理中汤治疗脾虚型经行泄泻的临床研究[D]. 广州: 广州中医药大学, 2009.

[28] 李春一, 姚美玉, 王秀霞等. 王秀霞运用温肾健脾法治疗经行口糜个案分析[J]. 光明中医. 2016, 31(20):2931-2932.

[29] 张玉珍. 中医妇科学[M]. 北京: 中国中医药出版社, 2013:170.

[30] 张佩霞. 丹栀逍遥散加味治疗绝经前后诸证 59 例[J]. 实用中医药杂志. 2011, 27(11):757.

致 谢

三年的研究生生活即将结束，在此向所有关心和帮助过我的人表示诚挚的感谢！首先感谢我的研究生导师刘卉老师，本论文从选题到完结全部过程都得到了导师悉心的指导。三年跟师学习中，导师严谨的治学态度、渊博的知识、孜孜不倦的求索精神和高尚的医德使我深受启迪，同时也激励我不断进步。老师的教诲使我受益终生，难以忘怀。

还要感谢山东中医药大学附属医院妇科各位老师的帮助和指导，同时感谢研究生处、临床医学院、中医妇科学教研室有关领导、老师对我们的付出和教诲。

感谢我的同门、舍友在学习生活中给予的关心和帮助。

感谢父母的养育之恩，感谢父母在读研期间给予的精神上和物质上的全力支持！

最后感谢所有参加论文评阅和答辩指导的老师，你们辛苦了！



全国中医药优秀期刊
中国科技期刊统计源期刊
中国期刊网全文数据库收录期刊
中国核心期刊(遴选)数据库收录期刊
中国学术期刊综合评价数据库(CAJCED)收录期刊

ISSN 1672-2779
CN 11-5024/R

主管 国家中医药管理局
主办 中华中医药学会
协办 北京中医药大学远程教育学院
中华中医药学会继续教育分会

中国中医药现代远程教育

- 情志致病与心脏神经官能症
- 琚玮教授膏方促进偏矮儿童生长经验总结
- 舌诊图像分割和特征提取的方法研究与应用
- 冬病夏治敷贴对频繁急性加重型慢阻肺患者血清IL-8、CRP的影响
- 补阳还五汤联合 α -硫辛酸注射液治疗气虚血瘀型糖尿病周围神经病变的临床观察

ISSN 1672-2779



2017年7月上半月刊

2017 13

第15卷 第13期 总第261期
Zhongguo Zhongyiyao Xiandai Yuancheng Jiaoyu

桃红四物汤配伍解表药物治疗桡骨远端骨折的临床观察	杨斌	易健健	刘建	陈善明(75)							
中老年高血压病辨证治疗临床研究	宋丽君	张晓娟	蔡晶	(77)							
温胆汤治疗缺血性卒中后抑郁的临床分析			杨冠华	(79)							
保湿干预联合脐疗治疗单纯性老年瘙痒症临床研究	周克伟	郑义宏	赵丽艳	刘之力	史月君(81)						
理中和胃方联合三联疗法治疗幽门螺杆菌相关性胃炎临床观察	侯静月	党中勤	李俊莹	马利节	(83)						
通腑安脏汤治疗支气管哮喘伴胃肠功能障碍的临床研究			齐晓	(85)							
培元汤配合穴位注射减轻结肠癌化疗副反应的临床研究	张宝昕	段圣刚	刘博	白振霞	张玉(87)						
黄芪建中汤改善脾胃虚弱型恶性肿瘤患者生存质量 20 例	于贺	卢亚品	孙根	底迎亚	杨亚琴(89)						
中西医汇讲//Integrated TCM and WM											
中西医结合治疗痤疮临床研究	来要水	向盈	易灿辉	张倩倩	徐继超	苗宇(91)					
浅谈抑郁性失眠的中医治疗			张文龙	王晓枫	旋静	(93)					
中西医结合治疗老年皮肤瘙痒症临床研究			胡巧玲	马春林	(95)						
扶正化痰散瘀联合西药治疗肝硬化伴脾功能亢进的临床观察			王九裕	彭冬琳	(97)						
针推启学//Acupuncture and Massage Guiding Learning											
中国穴位埋线疗法系列讲座(54)											
杨氏 3A+疗法“肘五针”埋线针刀治疗肘骨外上髁炎临床观察			马重兵	杨才德	(99)						
火疗结合针刺治疗腰椎间盘突出症的临床观察			程晋涛	张红艳	(102)						
护理讲堂//Nursing Class											
手穴点穴联合隔药饼灸治疗支气管哮喘临床的观察及护理			曹笑影	涂长英	龚慧玲	(104)					
营养风险对脑卒中患者偏瘫肢体功能的影响	蔡憐环	陈辉	陈盼	江苏珍	周榆龙	符卫卫(106)					
熏蒸塌渍配合牵引治疗腰椎间盘突出症的临床观察			谢瑛	余知依	(108)						
医案医话//Medical Instance											
从养生调神谈大学生心理保健	任婷	张鹏飞	黄建	罗威	龙敏	吴若霞(111)					
Vogt-小柳-原田综合征 1 例报告及发病特点探讨			胡晓	黄坡	张怀亮	燕树勋(113)					
董氏奇穴治疗功能失调性子宫出血临床体会					曹予	(115)					
海金沙石汤治疗尿结石的体会											
——学习崔金海主任医师治疗急性尿石症经验			朱永利	梁海英	崔金海	(117)					
健脾化痰法治疗原发性血小板增多症			丁莹	李景瑜	何华	(120)					
实验研究//Experimental Study											
延冰通心片对大鼠心肌梗死的保护作用及作用机制研究			韩冬	陶贵斌	张欣	孙云龙	曹占鸿	孙美玲	赵婉	尚坤	(122)
散瘀止痛散药品质量标准的研究					贾丽娜	杨思广	毕娜	(125)			
科研进展//Scientific Research Progress											
从高校统编中医临床学科教材不同版本谈浮、沉脉主病的认识			于晓飞	董正平	王科军	王斌胜	于京平	(128)			
两栖类药用动物 DNA 条形码鉴定研究进展			任诗怡	赵蕊	许亮	张梦蕊	王爽	王孟虎	(133)		
中医药治疗痛风性肾病的研究进展			王根萍	陈静	刘艳华	王卓	郑雷	(136)			
颈椎病中医疗法的临床研究进展					朱婷	金艳芳	(138)				
中药熏洗联合 NB-UVB 治疗特应性皮炎的临床分析			梁宝莹	宋丽芬	熊述清	李红毅	廖列辉	林颖	(140)		
针灸推拿治疗项痹的临床研究进展					徐立光	李孟媛	张敏	(144)			
舌诊图像分割和特征提取的方法研究与应用			高清河	刚晶	王和禹	刘海英	(147)				
妇科名老中医不孕症特色用药经验摘要			赵凯维	张玉辉	刘理想	(149)					
中西医结合治疗晚期卵巢癌的研究现状					周衍伍	李平	(152)				
柴胡疏肝散在消化内科的临床应用					段印会	张春玲	相世和	(154)			
莼丝子在妇科疾病中的典型应用					王娇	刘卉	(156)				
小儿肠系膜淋巴结炎中西医研究进展					张伟	赵凯赫	段晓征	(158)			
综合资讯//Comprehensive Information											
本刊郑重声明(27)关于变更投稿邮箱的通知(36)赤箭之古代医家药物解(103)中医万岁(119)偏枯之古医籍解(132)皂荚之前世今生(151)本刊稿约见本卷第 1 期第(IV)页											

关于专有使用权的说明

本刊已许可中国学术期刊(光盘版)电子杂志社在中国知网及其系列数据库产品中,以数字化方式复制、汇编、发行、信息网络传播本刊全文。作者向本刊提交文章发表的行为即视为同意我社上述声明。

菟丝子在妇科疾病中的典型应用

王 娇¹ 刘 卉^{2*}

(1 山东中医药大学硕士研究生2015级, 山东 济南 250014; 2 山东中医药大学附属医院妇科, 山东 济南 250011)

摘要:菟丝子具有固精缩尿、安胎、补益肝肾、明目、止泻之功效,现代药理研究表明其具有改善生殖功能、影响骨代谢、延缓衰老、调节免疫系统等作用,文章综述了中医文献及现代药理研究资料,以临床典型应用分析总结的方式,介绍了菟丝子治疗胎漏、胎动不安、滑胎、不孕症、绝经后骨质疏松、黄带等妇科疾病的优势及可行性,为妇科疾病的治疗提供依据及新思路。

关键词:菟丝子; 妇科疾病; 临床应用; 胎动不安; 带下; 辨证

doi:10.3969/j.issn.1672-2779.2017.13.068

文章编号:1672-2779(2017)-13-0156-03

The Typical Application of Dodder in Gynecological Diseases

WANG Jiao¹, LIU Hui²

(1. Grade 2015 Graduate, Shandong University of Traditional Chinese Medicine, Shandong Province, Jinan 250014, China;

2. Department of Gynecology, the Affiliated Hospital of Shandong University of Traditional Chinese Medicine, Shandong Province, Jinan 250011, China)

Abstract: Dodder has effect on solidifying fine urine, tocolysis, tonic liver and kidney, improving eyesight and relieving diarrhea. Modern pharmacological studies showed that it has improved reproductive function, affected bone metabolism, retarded the aging process, and regulated the immune system and other effects. The article reviewed the TCM literature and modern pharmacological research data. The advantages and feasibility of dodder in the treatment of fetal diseases, fetal movement, slippage, infertility, postmenopausal osteoporosis, yellow belt and other diseases were introduced in this paper, which provided new ideas and basis for the treatment of gynecological diseases.

Keywords: dodder; gynecological disease; clinical application; threatened abortion; leucorrhea; arthromyodynia

菟丝子是中医治疗妇科疾病的常用药,具有固精缩尿、安胎、补益肝肾、明目、止泻之功效^[1],因其平补肝、脾、肾之效,临床主要用于治疗阳痿遗精、尿频、宫冷不孕、肾虚腰痛、目暗便溏之肾阴虚证等^[2]。现代药理研究表明其具有改善生殖功能、影响骨代谢、延缓衰老、调节免疫系统等作用。众多方剂中或以菟丝子为主药,或以其为辅药皆能在妇科疾病的治疗中收到良好的疗效。本文将就菟丝子在妇科疾病的典型应用结合临床病例分析做如下总结。

1 功效与主治

菟丝子为一年生寄生草本植物,茎细柔,左旋缠绕,多分枝,黄褐色,寄主多为豆科、菊科等草本植物^[3]。入药为干燥成熟的种子,甘、温,归肝、脾、肾经。朱良春认为:“菟丝子是一味阴阳并补之品,它擅长补肾益精,助阴而不膩,温阳而不燥。”《本草正义》谓:“其味微辛,则阴中有阳,守而能走。”《药性论》谓:“治男女虚冷,填精益髓,去腰痛膝冷。”《神农本草经》谓:“主续绝伤,补不足,益气力,肥健。”《本草正义》云:“菟丝子养阴通络上品……皆有宣通百脉,温运阳和之意。”由此可见,菟丝子具有助阳、益气强阴、补髓填精之功效。

2 化学成分及药理作用

菟丝子的化学成分包含黄酮类、多糖类、生物碱类、萜类、甾体类、挥发油以及木质素等化合物^[4-8]。马红霞^[9]认为,菟丝子总黄酮可通过调节母胎界面内分泌-免疫网络平衡维持早孕,也可降低溴隐亭致SD孕

鼠流产模型的流产率,亦可通过调节滋养细胞的增殖与凋亡起到保胎作用。研究表明^[10],菟丝子对生殖系统的显著作用表现在菟丝子黄酮类物质有类雌激素样作用。菟丝子多糖可促进骨缺损修复,调整骨形成和骨吸收的关系^[11]。王宏贤^[12]揭示了菟丝子能起到延缓衰老的作用,它能提高皮肤内超氧化物歧化酶活性、清除过氧化产物、改善蛋白质代谢以及改善皮肤的形态。菟丝子也可能是一种以增强体液免疫及吞噬功能为主的免疫增强剂^[13]。此外,菟丝子还具有保肝作用,对心脑血管的保护作用,降血糖作用等^[14]。

3 临床典型应用

3.1 胎漏、胎动不安、滑胎 中医认为胎漏、胎动不安多由母体因素所致,或肾虚,或劳累过度,或跌扑闪挫,先治母病,则胎元亦安,继续生长发育;若母病不愈,则病情进一步发展为堕胎小产,而胎去难留矣。连方教授临床中对行体外受精-胚胎移植后的病人常规给予黄体酮支持黄体,在此基础上辨证施治予自创的以菟丝子为主药的参芪寿胎丸方中西医结合治疗,疗效显著:40例患者中,治愈35例,有效3例,无效2例,治愈率87.5%,总有效率95.0%^[15]。张锡纯《医学衷中参西录》言:“千百味药中得一最善流产之药,乃菟丝子是也;菟丝无根,蔓延草木之上,而草木为之不茂,其善吸他物之精气以自养可知。”菟丝子固摄冲任,为补肝脾肾三经要药,主续绝伤、补不足、益气力、肥健人,三经俱实,自能荫胎。现代中药药理研究证明,菟丝子能增强卵巢和垂体的反应性,促进离体培养人早孕绒毛组织HCG的分泌,能改善生殖内分泌功能,促进卵巢黄体的形成,有雌激素样活性,对下丘脑-垂体-性腺轴

* 通讯作者:



有一定的影响^[9]。故重用菟丝子为君药的寿胎丸加减治疗肾虚型胎漏、胎动不安、滑胎疗效显著。

3.2 不孕症 中医学认为,受孕的机理主要在肾中精气旺盛,天癸至,任通冲盛,月经调和,男女生殖之精相搏,合而成形,发育于胞宫中,乃成胎孕。肾主生殖,肾所藏之精是构成胎孕的原始物质,故不孕与肾的关系密切。周氏^[10]研究五子衍宗丸有类似性激素和促性腺激素的效果,具有促排卵的功效,发育不良症能奏良效。五子衍宗丸最早记载于道教的《悬解录》,有“古今种子第一方”之誉。王肯堂云:“嘉靖丁亥得于广信郑中函宅,药止五味,为繁衍宗嗣种子第一方也,故名。”五子衍宗丸以菟丝子为君药,具有填精补髓,种嗣衍宗的功能,故而医家用该方加减治疗非先天性生理缺陷的不孕症有一定疗效。刘元军^[11]根据经验,自拟加减菟丝子丸治疗子宫发育不良引起的不孕症30余例,效果可喜,总有效率达80%以上。边俊^[12]用四二五合方化裁治不孕不育20余剂,均取得较满意的疗效。可见,此方阴阳双补,于阴中求阳,阳中求阴,在妇科能起到促进排卵、调经促孕的作用。现代研究亦表明^[13],补肾类中药能提高雌激素水平,增加子宫内膜雌激素受体、孕激素受体含量有类似内分泌激素样作用,能够使下丘脑-垂体-卵巢轴的调节功能得以改善,方中在补肾的基础上加活血药又可改善患者的循环与微循环,增加卵巢血流量,诱发排卵及促进黄体发育,为孕育做好充分的准备。

3.3 绝经后骨质疏松 骨质疏松是绝经后妇女的高发疾病,为多因素性疾病:雌激素的缺乏、遗传因素、营养状况、生活习惯、体格、锻炼、月经周期紊乱、绝经早于40岁等均与发病有关^[14]。绝经后骨质疏松症依据其发病特点、症状、临床表现及转归可将其归属为中医学“骨痿”范畴。《素问·六节藏象论》载:“肾者,封藏之本,精之处也,其充在骨。”《医经原旨》中阐明了肾与骨的生理关系:“肾藏精,精生髓,髓生骨,故骨者肾之所合也;髓者精之所生也;精足则髓足,髓在骨内,髓足者则骨强。”绝经后妇女天癸竭,命门火弱,肾虚精亏,骨髓失充,骨骼失养,构成了绝经后骨质疏松症的基本病机,临床常见腰背关节等部位冷痛或酸痛、腰膝酸软无力、脉沉等症及体征,故温补肾阳、壮骨益髓是治疗绝经后骨质疏松症的基本治则。张红艳等^[15]临床观察骨质疏松症患者82例,随机分为观察组和对照组,各41例。观察组给予温肾壮骨汤治疗,对照组给予鲑鱼降钙素治疗,观察两组患者的疗效及不良反应。结果两组患者治疗情况比较,观察组优于对照组,差异有统计学意义($P<0.05$);观察组总有效率为87.81%,优于对照组的70.73%,差异有统计学意义($P<0.05$)。温肾壮骨方是以菟丝子等补肾药为君药,现代研究表明^[16],温肾壮骨汤中菟丝子、淫羊藿、杜仲、枸杞子等具有温阳益髓之功效,其促进骨髓细胞DNA合成,加快骨组织蛋白质合成及成骨细胞生

长。因此以菟丝子、熟地黄等补肾填精药为君药治疗骨质疏松效果显著。现代研究表明,菟丝子具有滋补肝肾的功效,能促进骨缺损修复,调整骨形成和骨吸收的关系,对卵巢功能衰退造成的骨质疏松有明显的防治作用^[17]。

3.4 黄带 西医认为,妇女黄带可见于阴道炎、宫颈炎、子宫内膜炎、盆腔炎等多种妇科疾病,治不得法,往往缠绵难愈。黄带多因经脉亏虚,带脉失约,湿热之邪乘虚而入所致,“补任脉之虚,兼清肾中之火”乃常规大法,然对缠绵难愈的黄带往往难于取效。孟间河派余景和曾有一例,常熟东乡某姓妇,就诊时“带下黄腻水,终日淋漓甚多,且臭秽不可近。”诊后椅垫皆湿,腥臭不堪。姑且以补中益气法,原方去当归,加菟丝子、龙骨、牡蛎,使其清气上升,脾有约束。不料服三剂,病已霍然。余景和认为五脏五带,黄带属脾经湿热,清气下陷,不能固摄,然而病已半年,亦难速效。以菟丝子、龙骨、牡蛎堵截其下焦,亦杜撰不经之见。

张梓凤^[18]临床观察叠经他法治疗仍缠绵难愈的黄带病人,方中(怀山药30g,生薏苡仁30g,苍术、白术各12g,黄柏10g,车前子12g,炒栀子10g)加用菟丝子30~50g后,结果全部病例在服药期间症状均明显减轻,观察3个月有42例痊愈。张梓凤^[19]认为,方剂配伍中加以大剂量菟丝子为主要药物,疗效显著,因其善入奇经,能峻补任脉之虚,而达固束带脉之功,且具有扶正不助邪的作用,是治病求本之法。

4 讨论

菟丝子药性平和,疗效可靠,作用广泛,副作用较少,是妇科常用药物之一。但其临床应用多集中在复方,且菟丝子的化学成分及药理作用的研究也较局限,主要集中在改善生殖功能、影响骨代谢、延缓衰老、调节免疫系统等方面。若能进一步完善相关临床和实验研究,深入探讨其有效成分和作用机制,则能扩大其临床应用价值,为妇科临床中治疗经带胎产等疾病的应用提供新的思路。

参考文献

- [1] 国家药典委员会.中国药典[S].北京:化学工业出版社,2005:217.
- [2] 林慧彬,广芳,李为玲.中药菟丝子的本草考证[J].时珍国医研究,1997,8(3):193.
- [3] 赵学敏.中华药海.第二部(上册).沈阳:辽宁出版社,1995:1694.
- [4] 郭澄,翰公羽,苏中武.南方菟丝子化学成分的研究[J].中国药学,1997,32(1):8-11.
- [5] Kwon YS. Steroids constituents from *Cuscuta chinensis* [J]. Nat Prod Sci, 2000, 6(3):135-138.
- [6] Anis E, Anis I, Ahmed S, et al. Alpha-glucosidase inhibitory constituents from *Cuscuta* [J]. Chem Pharm Bull, 2002, 50(1):112-115.
- [7] Xiang SX. The chemical constituents from the seeds of *Cuscuta japonica* [J]. Chin J Chem, 2001, 19(3):282-285.
- [8] Bao X, Wang Z, Fang J, et al. Structural features of an immunostimulating and antioxidant acidic polysaccharide from the seeds of *Cuscuta chinensis* [J]. Planta Med, 2002, 68(3):237-239.
- [9] 马红霞,尤昭玲,王若光.菟丝子总黄酮对人鼠流产模型血清P、PR、Th1、Th2细胞因子表达的影响[J].中药材,2008,31(8):1201-1204.
- [10] 夏卉芳.菟丝子的药理研究进展[J].现代医药卫生,2012,28(3):402.
- [11] 蔡西国,赵素霞.菟丝子黄酮干预去卵巢小鼠骨代谢研究[J].中药药理

- 与临床, 2007, 23(6):27-29.
- [12]王宏贤, 李寒冰. 葛丝子对亚急性衰老模型小鼠皮肤中相关指标的影响[J]. 四川中医, 2007, 25(12):13-15.
- [13]肖锦松, 玉竹, 葛丝子醇提物对烧伤小鼠免疫功能的影响. 中国中药杂志, 1990, 15(9):45.
- [14]王焕江, 等. 葛丝子的药理作用及其开发前景[J]. 中医药学报, 2012, 40(6):123.
- [15]刘啸凤, 连方, 王瑞霞. 连方教授治疗体外受精-胚胎移植后先兆流产40例经验总结[J]. 辽宁中医药大学学报, 2011, 13(5):169-170.
- [16]秦达念, 余白蓉, 余运初. 葛丝子黄酮对实验动物及人绒毛组织生殖功能的影响[J]. 中药新药与临床药理, 2000, 11(6): 349-350.
- [17]周智恒. 补肾法促进睾丸生精原理的实验研究[J]. 上海中医药杂志, 1992(7):26.
- [18]刘元军. 葛丝子丸治疗子宫发育不良不孕症 30 余例[J]. 中国中医药现代远程教育, 2011, 9(13):131.
- [19]边俊, 等. 四二五合方的临床应用体会[J]. 内蒙古中医药, 1997, 16(3):31-32.
- [20]葛争艳, 金龙, 刘建勋. 五子衍宗丸补肾壮阳作用的实验研究中国实验[J]. 中国实验方剂学杂志, 2010, 16(7):173-176.
- [21]Cooper C, Harvey N, Cole Z, et al. Developmental origins of osteoporosis: the role of maternal nutrition[J]. Adv Exp Med Biol, 2009, 646(2):31-39.
- [22]Ahlbory HG, Johnen O, Turner CH, et al. Bone loss and bone size after menopause[J]. N Engl J Med, 2004, 349(4):327-334.
- [23]李跃华, 薛李, 赵芳芳, 等. 原发性骨质疏松症中医证型分布及其与骨折关系研究[J]. 中国中西医结合杂志, 2010, 30(5):493-495.
- [24]张红艳, 赵晓辉. 温肾壮骨汤治疗骨质疏松症的疗效观察[J]. 中西医结合心脑血管病杂志, 2015, 3(15):107-108.
- [25]魏铭浩, 鲁俊山, 袁涛, 等. 温肾法治疗骨质疏松症的实验研究进展[J]. 长春中医药大学学报, 2011, 27(6):1059-1061.
- [26]张祥凤. 葛丝子治疗黄带有效[J]. 中医杂志, 2000, 41(10):586-587
- (本文编辑:李海燕 本文校对:刘文琼 收稿日期:2017-03-01)

小儿肠系膜淋巴结炎中西医研究进展

张伟¹ 赵凯赫¹ 段晓征^{2*}

(1 长春中医药大学研究生院, 吉林 长春 130117; 2 长春中医药大学附属医院儿童诊疗中心, 吉林 长春 130021)

摘要: 肠系膜淋巴结炎是小儿腹痛常见病之一, 近年来发病趋势逐渐增加, 我国医药卫生事业对该病的研究也在不断发展进步, 本文就近些年中西医学专家对该病的认识、治疗、临床经验等进行综述。

关键词: 儿科; 肠系膜淋巴结炎; 中医药治疗; 进展

doi:10.3969/j.issn.1672-2779.2017.13.069

文章编号:1672-2779(2017)-13-0158-03

Research Progress on Traditional Chinese Medicine and Western Medicine in the Treatment of Pediatric Mesenteric Lymphadenitis

ZHANG Wei¹, ZHAO Kaihe¹, DUAN Xiaozheng²

(1. Graduate School, Changchun University of Chinese Medicine, Jilin Province, Changchun 130117, China;

2. Children's Diagnosis and Treatment Center, the Affiliated Hospital of Changchun University of Chinese Medicine, Jilin Province, Changchun 130021, China)

Abstract: The mesenteric lymphadenitis in children with abdominal pain is one of the common diseases, and the incidence increased gradually in recent years. The research on this disease is also developing continuously in our country's medical and health undertakings. This article reviewed the understanding, treatment and clinical experience of integrated traditional Chinese and Western medical experts in recent years.

Keywords: pediatrics; mesenteric lymphadenitis; therapy of TCM; progress

小儿肠系膜淋巴结炎, 本病首先由Brennemann报道, 又称Brennemann综合征, 本病病因暂未明确, 故又称非特异性肠系膜淋巴结炎^[1], 好发于春、冬季, 是引起小儿腹痛的常见原因之一, 尤其多发于学龄期以下的儿童。临床表现多样化, 典型症状主要为腹痛、发热、呕吐, 腹痛部位多见于脐周及右下腹, 也可表现为上腹或全腹疼痛, 多为阵发性痉挛疼痛, 此外还可伴有胃肠道症状, 如: 腹泻、恶心、呕吐等。该病易复发, 若病程迁延, 还可见食欲欠佳, 形成再发性腹痛, 对患儿的身心健康及生活质量造成严重影响。临床上西医常采用抗感染及对症治疗措施治疗, 进而, 对小儿肠系膜淋巴结炎中医药治疗措施备受瞩目, 不仅缩短病程、降低复发率, 而且副作用小。

1 肠系膜淋巴结炎的病因

1.1 西医学研究 ①部分研究认为由于远端回肠的淋巴

引流十分丰富, 淋巴结多分布在回肠及结直肠, 上呼吸道感染后, 病毒及其毒素沿血循环到达该区域淋巴结, 可引起肠系膜或腹膜后淋巴结炎^[2]; ②另有研究对其病因进行深入探索, 表明可能为小儿淋巴系统的发育未成熟, 由于远端回肠的淋巴引流十分丰富, 淋巴结多分布在回肠及结直肠, 上呼吸道感染后, 病毒及其毒素沿血循环到达该区域淋巴结, 所以毒素在该部位停留而导致肠系膜淋巴结炎。其次回盲瓣的关闭作用使得肠内毒素或细菌的分解代谢产物在回肠末端的滞留时间较长而易于吸收, 极少数小儿肠系膜淋巴结炎可由细菌感染引起, 细菌以溶血链球菌多见, 金黄色葡萄球菌次之, 沙门菌引起的肠胃炎也可引发本病。此外, 血吸虫、阿米巴原虫偶尔也可引起肠系膜淋巴结炎^[3]; ③近年来发现3岁以上获肺炎支原体感染的儿童也可见急性肠系膜淋巴结炎。小儿尚未发育成熟的淋巴系统, 屏障作用差, 因此呼吸道、胃肠道的病毒、细菌等感染常累及肠系膜, 小肠内容物常因回盲瓣的

* 通讯作者